Pediatria: Resumo Definitivo para a Somativa

Nov 13, 2026 · @Luis Augusto Lobão Mendes

Como usar este material

Este documento cobre as 14 aulas da pasta (não existe Aula 14), na ordem do curso. Cada aula segue a mesma lógica: primeiro o raciocínio (por que acontece), depois o diagnóstico (como reconhecer e diferenciar), depois a conduta (o que usar, quando e em que dose), e por fim a caixa **Como cai na prova**, com as pegadinhas mais prováveis em questões de caso clínico e de "quantas afirmativas estão corretas".

Tudo foi extraído das aulas. Quando uma informação veio de diretriz e não do material (porque a aula trazia a tabela apenas como imagem, que não pude ler), ela está marcada como **[complemento de diretriz]**. As abreviações aparecem por extenso na primeira vez em cada aula.

Lacunas declaradas. As aulas de Asma (degraus do GINA, tabelas de crise), IVAS (escore de Centor), Diarreias (tabelas de agentes e Plano ABC) e Meningite (tabela de líquor) tinham conteúdo em imagem. Onde completei, marquei. A pasta de provas antigas não abriu para a conta conectada; as questões do final seguem o formato que você descreveu, não o estilo exato da banca.

Formato provável da prova e onde concentrar o estudo

A distribuição informada soma cerca de 30 questões, e quase um terço vem de três blocos: adolescência e puberdade (6), hepatoesplenomegalia (3) e diarreia (2). TDAH e TEA ficam para a segunda chamada e a prova especial, então descem para o fim da fila.

Tema	Questões	Onde está no material	O que dominar
Adolescência e puberdade	6	Aulas 10 e 13 (e Aula 12 como apoio)	Idades (OMS, ECA, 8 e 9 anos), ciclos anovulatórios, dismenorreia, contracepção, ginecomastia, bullying, PIMU, gaming disorder, automutilação, CFM 2025, cálcio e vitamina D, central versus periférica, exames, análogo de GnRH
Hepatoesplenomegalia	3 (fácil, média, difícil)	Aula 11	Limites normais, pistas da anamnese, mecanismos, pancitopenia (calazar versus leucemia), os 4 casos
Diarreia	2	Aula 8, **aula de Urgência e Diarreia** e cartaz do Ministério da Saúde	**Planos A, B e C com números exatos**, classificação pelo conjunto, vômito não é falha da SRO, fenótipos
IVAS	2 (uma isolada, uma com otite)	Aula 3	Bacteriana versus viral, penicilina benzatina, critérios de antibiótico na OMA
Meningite	2	Aula 7	Líquor, agente e empírico por idade, dexametasona, profilaxia

Tema	Questões	Onde está no material	O que dominar
Doenças de pele	2	**Aula 14 (Doenças dermatológicas)**	Fisiológico do RN, eritema tóxico, lesões vasculares, dermatite de fraldas, seborreica versus atópica, micoses, escabiose, pediculose, impetigo, erisipela versus celulite, acne, fotoproteção
Doenças exantemáticas	2 (uma com esplenomegalia)	Aula 15	Tabela-mestra; mononucleose é a ponte com esplenomegalia
Urgência isolada	1	**Aula de Urgência e Diarreia**	Triângulo da impressão inicial, ABCDE, choque compensado (PA normal não exclui), SAMPLE, caso Miguel
Urgência dentro das doenças	1	Tabela de urgências deste documento	Meningococcemia, desidratação grave, crise asmática grave, neutropenia febril, SSJ/NET
Bronquiolite e coqueluche	1 a 2	Aula 6	O que não fazer na bronquiolite; coqueluche abaixo de 6 meses
Asma	1 fácil	Aula 5	Base do tratamento e da crise
Pneumonia	1	Aula 4	Taquipneia, sinais de perigo, internação, antibiótico

Tema	Questões	Onde está no material	O que dominar
Hemograma	1 misturada	Aula 1	Ferropriva, leucemoide versus LLA, PTI, linfócitos atípicos
TDAH e TEA	Segunda chamada e especial	Aula 9	Ler só se sobrar tempo

As duas aulas enviadas depois (Urgência e Diarreia; Aula 14, Doenças dermatológicas) são da mesma professora e cobrem exatamente os itens “urgência”, “diarreia” e “doenças de pele” da lista. Elas somam até 5 questões e merecem prioridade igual à de hepatoesplenomegalia.

Plano de estudo: sexta, domingo e segunda

O princípio é simples: ler explicação uma vez, testar-se imediatamente, e revisar apenas o que errou. Leitura passiva repetida dá sensação de domínio sem gerar recuperação na hora da prova.

Dia	Bloco	Conteúdo	Tarefa ativa
Sexta	Noite	Aulas 10 e 13 (adolescência e puberdade)	Escrever de memória: idades, central versus periférica, quando operar ginecomastia, CFM 2025
Domingo	Manhã	Aula 11, Aula 8 com os Planos A, B e C, e a aula de Urgência (caso Miguel)	Classificar 3 crianças no quadro de hidratação; refazer o caso Miguel sem olhar
Domingo	Tarde	Aula 14 (pele), Aulas 3 e 7	Montar de memória as tabelas “seborreica versus atópica” e “erisipela versus celulite”
Domingo	Noite	Aula 15, tabela de urgências, Aulas 1, 4, 5 e 6	Tabela-mestra dos exantemas em branco
Segunda	Manhã	Simulado 2 (formato provável), 60 min	Corrigir pelo gabarito comentado
Segunda	Tarde	Reler só o que errou; depois o Banco 1	Refazer as erradas

Dia	Bloco	Conteúdo	Tarefa ativa
Segunda	Noite	Mapa de medicamentos e caixas “Como cai na prova”	Dormir cedo

Técnica para as questões de "quantas afirmativas estão corretas". Julgue cada afirmativa isoladamente como V ou F antes de olhar as alternativas, e escreva a letra ao lado. As afirmativas falsas costumam trocar um número (idade, dose, dias), inverter uma relação (aumenta por diminui) ou generalizar com "sempre" e "nunca". Desconfie dessas palavras.

Aula 1. Hemograma na pediatria

O hemograma infantil se lê sempre contra a faixa etária: o que é normal no recém-nascido é anormal no escolar. A aula recomenda triagem com 1 ano de idade com hemograma, PCR (proteína C reativa), ferro sérico e ferritina.

Série vermelha: como raciocinar

1. **Existe anemia?** Anemia é hemoglobina abaixo de 2 desvios padrão para a idade. Regra de conferência: hematócrito ≈ hemoglobina × 3.
2. **Qual o tamanho da hemácia?** VCM (volume corpuscular médio): abaixo de 80 é microcítica, 80 a 100 normocítica, acima de 100 macrocítica.
3. **As hemácias são iguais entre si?** RDW (índice de anisocitose) normal 10 a 15%; acima de 15% é anisocitose. Na ferropenia o RDW sobe **antes** de a hemoglobina e o VCM caírem, porque a medula começa a liberar células menores misturadas às antigas.
4. **A medula está respondendo?** Reticulócitos altos significam que a medula produz e a perda está na periferia (sangramento ou hemólise). Reticulócitos baixos significam defeito de produção (falta de ferro, aplasia, infiltração).

Anemia ferropriva

Por que acontece: baixa reserva ao nascer, crescimento rápido e dieta pobre em ferro (leite de vaca, introdução alimentar inadequada). **Pistas clínicas cobradas:** pica, pagofagia (comer gelo), pernas inquietas, palidez. **Laboratório:** microcitose, hipocromia, RDW alto, ferritina baixa, reticulócitos baixos.

Situação	Dose de ferro elementar	Quando e por quanto tempo
Profilaxia sem fator de risco	1 mg/kg/dia	Dos 6 meses aos 2 anos

Situação	Dose de ferro elementar	Quando e por quanto tempo
Profilaxia com fator de risco (prematuro, baixo peso)	1 mg/kg/dia, até 4 mg/kg/dia no baixo peso	Dos 3 meses aos 2 anos
Tratamento	3 a 6 mg/kg/dia	3 a 6 meses; reavaliar com hemograma e reticulócitos em 30 a 45 dias

Detalhe de prova: não dar o ferro junto com leite ou fórmula, porque o cálcio reduz a absorção. A resposta esperada primeiro é a subida de reticulócitos; a ferritina é a última a normalizar, por isso o tratamento continua meses após a hemoglobina normalizar.

Série branca

- **Neutrofilia (acima de 7.000):** procure desvio à esquerda (formas jovens), que sugere infecção bacteriana. Causas não infecciosas, por demarginalização dos neutrófilos aderidos ao endotélio: adrenalina, convulsão, dor, corticoide e exercício.
- **Reação leucemoide:** leucócitos acima de 50.000 com desvio, mas com células **maduras** e reacionais. Causas: infecção bacteriana grave, tuberculose, brucelose, toxoplasmose, glomerulonefrite, artrite reumatoide, insuficiência hepática, cetoacidose diabética.
- **Leucemia linfoide aguda (LLA):** o que a diferencia da reação leucemoide é o acometimento das outras linhagens e a presença de **blastos**: anemia, plaquetopenia, leucocitose com blastos, hepatoesplenomegalia, dor óssea e equimoses.
- **Neutropenia:** leve 1.000 a 1.500; moderada 500 a 1.000; grave abaixo de 500. **Neutropenia febril é emergência** e se trata com cefepime.
- **Linfócitos atípicos:** pensar em vírus Epstein-Barr (mononucleose; acima de 20% é fortemente sugestivo, ver Aula 15).

Plaquetas

- **Trombocitose (acima de 450.000):** quase sempre reacional (infecção, inflamação, ferropenia), mediada pela trombopoetina. Lembre que na doença de Kawasaki a plaquetose surge na 3ª semana.
- **Trombocitopenia (abaixo de 150.000):** três mecanismos: produção diminuída, destruição aumentada ou sequestro (baço grande).
- **PTI (púrpura trombocitopênica imune):** criança previamente hígida, cerca de 3 semanas após infecção viral, com petequias e plaquetas baixas isoladas (sem anemia, sem blastos, sem visceromegalia). De 80 a 85% resolvem só com observação; corticoide ou imunoglobulina apenas se houver sangramento.

- **Plaquetopenia neonatal:** causas perinatais, infecções, CIVD (coagulação intravascular disseminada), PTI ou lúpus materno e causa isoimune.

> **Como cai na prova.** (1) RDW alto com hemoglobina ainda normal = ferropenia inicial. (2) Leucocitose acima de 50.000 com células maduras = leucemoide; com blastos e citopenias = LLA. (3) Plaquetopenia isolada pós-viral em criança bem = PTI; a conduta na maioria é observar. (4) Profilaxia de ferro sem risco começa aos 6 meses, não aos 3. (5) Neutropenia febril: cefepime, sem esperar cultura.

Aula 2. Antibioticoterapia e cálculo de doses

Em crianças abaixo de 7 anos usamos formas líquidas e toda dose é calculada em mg/kg/dia, depois dividida pelo número de tomadas. Acima de 30 kg, usa-se a dose de adulto (por exemplo, amoxicilina 500 mg de 8/8 h, que equivale a 10 mL da suspensão de 250 mg/5 mL).

Como calcular sem errar

A conta tem três passos: (1) dose diária = peso × mg/kg/dia; (2) dose por tomada = dose diária ÷ número de tomadas; (3) volume = dose por tomada ÷ concentração (mg/mL).

Exemplo. Criança de 15 kg, amoxicilina 50 mg/kg/dia de 8/8 h, suspensão 250 mg/5 mL (50 mg/mL). Dose diária 750 mg; por tomada 250 mg; volume 5 mL de 8/8 h.

Atalho da aula: volume por tomada = peso ÷ número de doses. Ele só funciona quando a concentração “encaixa” na dose (amoxicilina 250 mg/5 mL a 50 mg/kg/dia em 8/8 h divide por 3; em 12/12 h, por 2). Se a concentração ou a dose mudar, faça a conta completa.

Os quatro antibióticos da aula

Fármaco	Dose	Cobre	Usar em	Não usar em
Amoxicilina	50 a 100 mg/kg/dia, 8/8 ou 12/12 h; dose alta 80 a 100	Pneumococo, estreptococo do grupo A	Amigdalite, OMA, sinusite, PAC	Bactéria produtora de betalactamase
Amoxicilina com clavulanato	Mesma base de amoxicilina	Acrescenta S. aureus sensível, H. influenzae, Moraxella, E. coli, anaeróbios	Falha da amoxicilina, risco de resistência	Quando a amoxicilina isolada basta

Fármaco	Dose	Cobre	Usar em	Não usar em
Cefalexina (cefalosporina de 1ª geração)	50 a 100 mg/kg/dia, 6/6 ou 8/8 h	Gram-positivos, alguns gram-negativos urinários	Faringite (alergia leve), pele, ITU (infecção do trato urinário)	**OMA, sinusite, pneumonia**
Azitromicina	10 mg/kg/dia, 1 vez ao dia	Atípicos, B. pertussis, Chlamydia	PAC atípica, coqueluche, ISTs, alergia grave a penicilina	Primeira escolha em OMA ou sinusite

Por que a cefalexina falha em OMA e sinusite: ela não cobre bem o H. influenzae nem a Moraxella, que são justamente os agentes produtores de betalactamase dessas infecções.

Amoxicilina com clavulanato: o “jeitinho SUS”

O clavulanato é o responsável pela diarreia. Por isso, quando precisamos de dose alta de amoxicilina com proteção contra betalactamase, não aumentamos o clavulanato: mantemos cerca de 7,5 mg/kg/dia de clavulanato e completamos a amoxicilina com amoxicilina pura.

Apresentação	Amoxicilina/clavulanato por 5 mL	Proporção
Convencional (a do SUS)	250/62,5	4:1
ES	400/57	7:1
BD	600/42,9	14:1

Montagem: cerca de 30 mg/kg/dia de amoxicilina vindos da amoxicilina com clavulanato (4:1) mais 50 a 70 mg/kg/dia vindos da amoxicilina pura. **Exemplo da aula, 12 kg:** 2,5 mL de amoxicilina com clavulanato mais 4 mL de amoxicilina, ambos de 8/8 h por 7 dias.

Azitromicina: farmacologia que cai

Macrolídeo bacteriostático que age na subunidade 50S do ribossomo, não deve ser dado junto de alimento e tem excreção fecal. **Vômito após a dose:** se imediato, repetir a dose inteira; aos 15 minutos, repetir metade; após 30 minutos, não repetir (já foi absorvida).

> **Como cai na prova.** (1) Cálculo de volume com suspensão de 250 mg/5 mL. (2) Cefalexina para OMA ou sinusite é afirmativa falsa. (3) Diarreia da amoxicilina com clavulanato vem do clavulanato. (4) Azitromicina é dose única diária de 10 mg/kg. (5) Acima de 30 kg, dose de adulto.

Aula 3. IVAS: amigdalite, otite média aguda e sinusite

As IVAS (infecções de vias aéreas superiores) são majoritariamente virais. A pergunta central de cada uma é a mesma: **quando a bactéria é provável o bastante para justificar antibiótico**, e qual antibiótico cobre os agentes daquela região.

Faringoamigdalite

Epidemiologia que decide a conduta: de 70 a 90% são virais. O estreptococo beta-hemolítico do grupo A (EBGA) responde por 20 a 30% dos casos entre 5 e 15 anos, e quase nunca causa amigdalite abaixo dos 3 anos.

Sugere bactéria (EBGA)	Sugere vírus
Início abrupto, febre alta	Início gradual
Linfonodos cervicais anteriores dolorosos	Tosse, coriza, rouquidão
Exsudato ou placas grandes	Conjuntivite, aftas, diarreia
Ausência de tosse e coriza	Idade abaixo de 3 anos

[complemento de diretriz] O escore de Centor modificado (McIsaac) soma 1 ponto para febre acima de 38 °C, ausência de tosse, adenopatia cervical anterior dolorosa, exsudato amigdaliano e idade de 3 a 14 anos (subtrai 1 ponto acima de 45 anos). Escores altos reforçam a indicação de teste ou tratamento.

Teste rápido: alta especificidade e baixa sensibilidade. Positivo, trate. Negativo, não descarta: faça cultura.

Tratamento e por que tratá-la: o objetivo principal é prevenir febre reumática.

Situação	Escolha
Primeira linha	Penicilina benzatina 50.000 UI/kg IM dose única (abaixo de 27 kg 600.000 UI; acima de 27 kg 1.200.000 UI) ou amoxicilina por 10 dias (penicilina V também serve)

Situação	Escolha
Falha em 48 a 72 h	Amoxicilina com clavulanato por 10 dias
Alergia leve à penicilina	Cefalexina
Alergia grave	Clindamicina ou azitromicina (azitromicina por 5 dias)

Abscesso periamigdaliano: voz “de batata quente”, trismo, desvio da úvula. Conduta: drenagem pelo otorrinolaringologista mais amoxicilina com clavulanato ou clindamicina.

Amigdalite de repetição: 3 episódios em 6 meses ou 4 em 1 ano.

Otite média aguda (OMA)

Raciocínio: a tuba auditiva da criança pequena é curta e horizontal; uma IVAS viral obstrui a tuba e a secreção retida na orelha média se infecta. Pico entre 6 e 24 meses; rara abaixo de 6 meses. Agentes: vírus, pneumococo, H. influenzae e Moraxella. **O sinal mais confiável é o abaulamento da membrana timpânica.** A resistência do pneumococo ocorre por alteração das PBP (proteínas ligadoras de penicilina), e não por PBP2a (mecanismo do S. aureus resistente à oxacilina) nem por betalactamase; por isso se vence com **dose alta** de amoxicilina.

Antibiótico imediato	Observação por 48 a 72 h permitida
Abaixo de 6 meses (sempre)	Acima de 6 meses
Grave: febre de 39 °C ou mais, dor intensa, otorreia	Febre abaixo de 39 °C e dor leve
Abaixo de 2 anos com OMA bilateral	OMA unilateral sem otorreia
Toxemia, dor acima de 48 h, falha	Família com acesso garantido ao retorno
Sem acesso ao seguimento	

Linha	Escolha
1ª	Amoxicilina; dose alta se frequenta creche ou usou antibiótico recente
2ª	Amoxicilina com clavulanato; cefuroxima (alergia leve); clindamicina; levofloxacino

Linha	Escolha
3ª	Ceftriaxona 50 mg/kg IM por 1 a 3 dias

Duração: acima de 2 anos, 5 a 7 dias; abaixo de 2 anos, 7 a 10 dias.

Sinusite bacteriana aguda

Desenvolvimento dos seios (explica a idade): etmoidais e maxilares já existem ao nascer; esfenoidal aos 5 anos; frontal aos 7 a 8 anos. Logo, sinusite frontal em lactente é impossível.

Agentes: pneumococo 30%, H. influenzae 30% (10 a 42% produzem betalactamase), Moraxella 10% (100% produzem betalactamase).

Diagnóstico clínico, por um de três padrões:

1. Persistente: sintomas por mais de 10 dias sem melhora.
2. Dupla piora: melhora inicial e depois nova piora.
3. Grave: febre acima de 39 °C com secreção purulenta por 3 a 4 dias.

Tomografia apenas em complicação, recorrência ou falha terapêutica; radiografia não é necessária.

Tratamento: amoxicilina é a primeira linha. Amoxicilina com clavulanato em dose alta se houver risco de resistência: idade abaixo de 2 ou acima de 65 anos, creche, antibiótico ou internação recentes, comorbidade, imunossupressão. Em crianças, 10 a 14 dias. Evitar macrolídeos (alta resistência do pneumococo).

> **Como cai na prova.** (1) Amigdalite com placas em criança de 2 anos: pense em vírus. (2) Teste rápido negativo não exclui; peça cultura. (3) Penicilina benzatina: corte em 27 kg. (4) OMA abaixo de 6 meses sempre recebe antibiótico. (5) Abaulamento é o achado mais específico. (6) Resistência do pneumococo é por PBP alterada, vencida com dose alta. (7) Sinusite é diagnóstico clínico: 10 dias, dupla piora ou grave.

Aula 4. Pneumonia adquirida na comunidade (PAC)

Na criança, o sinal mais sensível de pneumonia é a **taquipneia**, não a ausculta. Por isso a OMS (Organização Mundial da Saúde) define o diagnóstico de triagem pela frequência respiratória (FR) e a gravidade pelos sinais de perigo.

Taquipneia pela OMS

Idade	FR que define taquipneia
Abaixo de 2 meses	60 ou mais (já é sinal de perigo)
2 a 12 meses	50 ou mais
12 a 60 meses	40 ou mais

Sinais de perigo e gravidade

Abaixo de 2 meses: FR de 60 ou mais, tiragem subcostal, febre ou hipotermia, recusa de 3 mamadas, sibilância ou estridor, sensório alterado. Qualquer um interna.

De 2 meses a 5 anos: tiragem, estridor, recusa de líquidos, convulsão ou alteração do sensório, vômitos incoercíveis.

PAC grave: temperatura de 38,5 °C ou mais, FR acima de 70 no lactente ou acima de 50 na criança maior, gemência, batimento de asa do nariz (BAN), apneia, cianose, saturação abaixo de 90%, tempo de enchimento capilar de 2 s ou mais.

Indicações de internação: PAC grave, tiragem, incapacidade de beber, cianose, problema social, desidratação, comorbidade, impossibilidade de via oral, e idade de 3 a 6 meses (exceto se viral e em bom estado geral).

Agente por idade e por quadro

Quadro	Agente	Pistas
Neonatal precoce (abaixo de 3 dias)	Estreptococo do grupo B, bacilos gram-negativos, Listeria	Adquirido no canal de parto
Neonatal tardia	S. aureus, S. epidermidis, gram-negativos	Ambiente hospitalar
Pneumonia afebril do lactente	Chlamydia trachomatis	1 a 3 meses, **sem febre**, conjuntivite prévia, eosinofilia; tratar com azitromicina ou claritromicina
PAC típica	Pneumococo, H. influenzae, Moraxella	Febre alta, PCR muito elevada, consolidação com broncograma aéreo

Quadro	Agente	Pistas
PAC atípica (acima de 5 anos)	Mycoplasma pneumoniae	Quadro arrastado, padrão intersticial, leucócitos normais; IgM em 7 a 10 dias, IgG subindo 4 vezes

Notas: a pesquisa de antígeno pelo látex continua válida até 5 dias após início do antibiótico. A vacina pneumocócica 10-valente não cobre os sorotipos 19A e 3.

Tratamento: quando usar qual

Cenário	Escolha
Ambulatorial típica	Amoxicilina (dose alta se risco de resistência) por 5 a 7 dias, ou 3 a 5 dias após a melhora; reavaliar em 48 a 72 h
Ambulatorial atípica	Azitromicina por 5 dias
Internado abaixo de 2 meses, precoce	Ampicilina mais gentamicina
Internado abaixo de 2 meses, tardia	Oxacilina mais gentamicina
Internado a partir de 2 meses	Ampicilina (ou penicilina cristalina) endovenosa
Suspeita de S. aureus	Oxacilina
Alternativas	Macrolídeo (atípico); amoxicilina com clavulanato
Com derrame pleural	Ampicilina ou penicilina cristalina; amoxicilina com clavulanato; ceftriaxona mais oxacilina

Derrame pleural parapneumônico

O derrame evolui em fases, e a conduta depende da fase porque, quanto mais organizado, menos o antibiótico sozinho alcança o espaço pleural.

Fase	Tempo	Conduta
Exsudativa	24 a 72 h	Antibiótico apenas
Fibrinopurulenta	7 a 10 dias	Drenagem, videotoracoscopia (VATS) ou fibrinolítico
Organização	2 a 4 semanas	Decorticação

Imagem: radiografia em decúbito lateral detecta acima de 50 mL; ultrassonografia detecta de 5 a 50 mL.

Drenar se: pus, bactéria no Gram ou cultura, pH abaixo de 7,1, glicose abaixo de 40 mg/dL ou DHL (desidrogenase lática) acima de 1.000. Sem melhora em 48 a 72 h após drenagem: VATS ou alteplase.

> **Como cai na prova.** (1) Lactente de 8 meses com FR 52 tem taquipneia; com 14 meses e FR 42 também. (2) Lactente de 2 meses, afebril, tosse, conjuntivite e eosinofilia: Chlamydia, azitromicina. (3) Escolar com quadro arrastado e intersticial: Mycoplasma, azitromicina. (4) Ambulatorial típica: amoxicilina, nunca cefalexina. (5) Derrame com pH 7,0 ou glicose 30: drenar.

Aula 5. Asma

Asma é doença inflamatória crônica das vias aéreas com hiper-reatividade brônquica e obstrução variável e reversível. Entender isso explica o tratamento: o **corticoide inalatório trata a inflamação (controle)** e o **broncodilatador trata o broncoespasmo (alívio)**. Faz parte da marcha atópica (dermatite atópica, rinite, asma).

Diagnóstico

Acima de 5 anos: clínica compatível mais espirometria, que deve ser feita **antes** de iniciar o tratamento, mostrando obstrução com resposta ao broncodilatador.

Abaixo de 5 anos: diagnóstico clínico, porque a criança não colabora com a espirometria. Sustentam o diagnóstico: sibilância recorrente, tosse ou chiado ao rir ou chorar, ausência de outra explicação e resposta ao broncodilatador ou ao corticoide inalatório.

Pouco provável que seja asma: tosse isolada, expectoração crônica, ruídos inspiratórios (estridor sugere via aérea alta).

Diagnósticos diferenciais: fibrose cística, bronquiectasia, discinesia ciliar, corpo estranho, displasia broncopulmonar, cardiopatia, tuberculose, traqueomalácia, doença do refluxo gastroesofágico.

Avaliação do controle (últimas 4 semanas)

[complemento de diretriz, GINA] Quatro perguntas: sintomas diurnos mais de 2 vezes por semana; despertar noturno por asma; uso de broncodilatador de alívio mais de 2 vezes por semana; limitação de atividade. Nenhuma: controlada. Uma ou duas: parcialmente controlada. Três ou quatro: não controlada.

Tratamento de manutenção

Da aula: o corticoide inalatório (CI) é a base do tratamento; efeitos adversos locais são disfonia e candidíase oral, prevenidos lavando a boca após o uso. O montelucaste é o único antagonista de leucotrienos aprovado abaixo de 12 anos. A associação CI com LABA (beta-2 agonista de longa ação) é necessária em 3 a 10% dos pacientes. Referência: GINA 2025.

[complemento de diretriz, GINA, degraus resumidos]

Degrau	6 a 11 anos	5 anos ou menos
1	CI em dose baixa sempre que usar o broncodilatador de alívio	Broncodilatador de alívio; curso de CI nas viroses
2	CI em dose baixa diária (alternativa: montelucaste)	CI em dose baixa diária (alternativa: montelucaste)
3	CI dose baixa com LABA, ou CI dose média	CI em dose dobrada (“dose baixa dobrada”)
4	CI dose média com LABA; encaminhar ao especialista	Manter e encaminhar ao especialista
5	Fenótipo e biológicos (especialista)	Especialista

Crise asmática: o que usar e quando

Medicamento	Quando	Detalhe que cai
Salbutamol (beta-2 de curta ação)	Toda crise	Spray com espaçador na crise leve a moderada; nebulização na grave
Brometo de ipratrópio	Crise moderada a grave, junto do salbutamol na sala de emergência	Reduz internação; **sem benefício depois de internado**
Sulfato de magnésio	Crise grave sem resposta inicial	25 a 75 mg/kg (máximo 2 g) endovenoso em 20 a 30 min
Corticoide sistêmico **[complemento]**	Crise moderada a grave	Prednisolona 1 a 2 mg/kg/dia (máx. 40 mg) por 3 a 5 dias
Oxigênio **[complemento]**	Saturação baixa	Alvo de 94 a 98%

A aula cita o escore PASS para avaliar gravidade da crise acima de 2 anos; a tabela estava em imagem e não pôde ser lida. Sinais clássicos de crise grave **[complemento]**: fala apenas palavras, agitação ou sonolência, uso intenso de musculatura acessória, saturação abaixo de 90%, tórax silencioso.

> **Como cai na prova.** (1) Espirometria antes do tratamento. (2) Abaixo de 5 anos o diagnóstico é clínico. (3) Montelucaste é o único antileucotrieno abaixo de 12 anos. (4) Ipratrópio só no pronto atendimento; não ajuda no internado. (5) Magnésio: dose máxima 2 g. (6) Candidíase oral pelo CI previne-se lavando a boca. (7) Controle avalia as últimas 4 semanas.

Aula 6. Bronquiolite viral aguda e coqueluche

Bronquiolite viral aguda

Definição operacional: primeiro episódio de sibilância em criança abaixo de 2 anos, desencadeado por vírus. O VSR (vírus sincicial respiratório) causa 50 a 80% dos casos, com pico no outono. Se é o segundo ou terceiro episódio de chiado, pense em lactente sibilante ou asma, não em bronquiolite.

Mecanismo: o vírus necrosa o epitélio dos bronquíolos; muco, restos celulares e edema obstruem vias aéreas muito finas, gerando aprisionamento de ar (hiperinsuflação) e atelectasias. Como não há broncoespasmo verdadeiro como na asma, **broncodilatador e corticoide não funcionam**.

Evolução típica:

1. Dias 1 a 3: febre baixa e coriza.
2. Dias 3 a 5: taquidispneia e sibilância (pico de gravidade).
3. Duração total de 2 a 3 semanas (a tosse persiste).

Diagnóstico clínico. Radiografia só se dúvida: infiltrado peribrônquico, hiperinsuflação, atelectasia.

Internar se: apneia, toxemia, FR acima de 70, desidratação ou recusa alimentar, fatores de risco (prematuridade, idade abaixo de 3 meses, cardiopatia, pneumopatia, imunodeficiência **[fatores listados como complemento; a tabela estava em imagem]**). Bronquiolite grave é notificada como SRAG (síndrome respiratória aguda grave).

Recomendado	Não recomendado
Oxigênio se saturação abaixo de 92%	Corticoide

Recomendado	Não recomendado
Lavagem nasal e aspiração	Adrenalina
Hidratação	Salina hipertônica
Cânula nasal de alto fluxo	Fisioterapia respiratória
Broncodilatador apenas como teste terapêutico (suspender se não houver resposta)	Antivirais

Prevenção: quem recebe o quê

Estratégia	Quem	Efeito
Vacina materna (Abrysvo)	Gestante de 32 a 36 semanas (no SUS, 28 a 36)	Proteção de 82% abaixo de 3 meses e 69% abaixo de 6 meses
Nirsevimabe	Dose única; abaixo de 1 ano, ou abaixo de 2 anos com fator de risco	Anticorpo monoclonal de longa duração
Palivizumabe	Grupos de risco	**Apenas profilaxia**, nunca tratamento

Coqueluche

Agente: Bordetella pertussis. Incubação de 5 a 10 dias. Transmite de 5 dias antes até 3 semanas após o início dos paroxismos.

Fase	Duração	Quadro	Por que importa
Catarral	1 a 2 semanas	Parece resfriado	**Mais transmissível**; antibiótico aqui encurta a doença
Paroxística	2 a 6 semanas	Acessos de tosse, guincho inspiratório, vômitos pós-tosse, apneia	Antibiótico já não muda o curso, mas reduz transmissão
Convalescença	2 a 6 meses	Tosse residual	Antibiótico não indicado

Abaixo de 6 meses: não há guincho; a doença se manifesta por **apneia, cianose e bradicardia**. É a faixa de maior letalidade (cerca de 1% abaixo de 2 meses).

Laboratório: leucocitose com **linfocitose** (a toxina pertussis impede a saída dos linfócitos do sangue). Radiografia com “coração felpudo”.

Exame	Janela útil
Cultura	Até 2 semanas
PCR (reação em cadeia da polimerase)	0 a 4 semanas
Sorologia	2 a 12 semanas

Tratamento: azitromicina por 5 dias; fenobarbital se convulsão. **Complicação mais comum:** pneumonia (22%). **Isolamento:** precaução para gotículas por 3 semanas, ou até 5 dias de antibiótico.

Quimioprofilaxia (azitromicina 5 dias) para contatos domiciliares e para contatos que sejam: abaixo de 1 ano, gestantes, imunodeficientes, pneumopatas, pessoas que convivem com alto risco e profissionais que trabalham com crianças.

Vacinação: 2, 4 e 6 meses, reforços aos 15 meses e 4 anos; dTpa na gestante a partir de 20 semanas, **em toda gestação**.

> **Como cai na prova.** (1) Primeiro chiado, abaixo de 2 anos, outono: bronquiolite; segundo chiado não é bronquiolite. (2) Afirmativas que indicam corticoide, salina hipertônica ou fisioterapia são falsas. (3) Palivizumabe não trata. (4) Lactente de 2 meses com apneias e cianose após tosse, sem guincho: coqueluche. (5) Linfocitose importante com tosse paroxística: coqueluche. (6) Antibiótico na convalescença: falso. (7) dTpa em toda gestação.

Aula 7. Meningoencefalites

A conduta inteira gira em torno de três decisões: (1) qual agente é provável para aquela idade, (2) o líquor é bacteriano, viral ou tuberculoso, (3) quem precisa de quimioprofilaxia.

Quadro clínico

Criança maior: febre, cefaleia, vômitos, rigidez de nuca, sinais de Kernig e Brudzinski. **Lactente:** sinais menos específicos; fontanela abaulada em 20 a 30% e convulsões em 20 a 50%. Hemoculturas são positivas em 80 a 90% das meningites bacterianas.

Meningococcemia: 15 a 20% são fulminantes, com síndrome de Waterhouse-Friderichsen (hemorragia adrenal) e letalidade de cerca de 40% (ver Aula 15).

Agente por idade

Idade	Agentes	Empírico
Recém-nascido	E. coli, estreptococo do grupo B, Listeria	Ampicilina mais gentamicina (ou ampicilina mais cefotaxima)
1 a 3 meses	Os neonatais mais pneumococo, meningococo, H. influenzae b	Cefotaxima ou ceftriaxona (com ampicilina se Listeria possível)
3 meses a 5 anos	Meningococo e pneumococo	Ceftriaxona ou cefotaxima
Acima de 5 anos	Pneumococo e meningococo	Ceftriaxona ou cefotaxima
Válvula de derivação (DVP)	S. epidermidis, S. aureus	Cobertura estafilocócica

Por que a ampicilina no recém-nascido: **Listeria é naturalmente resistente às cefalosporinas**. Por que não ceftriaxona abaixo de 28 dias: ela desloca a bilirrubina da albumina (risco de kernicterus) e precipita com cálcio. Se houver suspeita de pneumococo resistente, acrescentar vancomicina.

Líquor: o diferencial que mais cai

Parâmetro	Bacteriana	Viral	Tuberculosa
Células	Muito elevadas (frequentemente acima de 200, muitas vezes acima de 1.000)	Moderadamente elevadas	Moderadamente elevadas
Predomínio	Neutrófilos	Linfócitos	Linfócitos
Glicose	Baixa	Normal	**Muito baixa**
Proteína	Alta	Normal ou pouco alta	Muito alta
Pista extra	Gram positivo	Enterovírus no verão	Paralisia de nervos cranianos, evolução arrastada

Gram: cocos gram-positivos aos pares = pneumococo; diplococos gram-negativos = meningococo; cocobacilos gram-negativos = H. influenzae; bacilos gram-positivos = Listeria. **Cultura é o padrão-ouro.**

Punção traumática: descontar 1 leucócito para cada 500 hemácias; a proteína sobe 1 a 1,5 mg/dL a cada 1.000 hemácias. Exemplo da aula: 23 leucócitos com 9.000 hemácias; 23 menos 9.000/500 (18) = 5 leucócitos reais.

Punção lombar: entre L3 e L4. Tomografia antes se houver déficit focal. Contraindicações: instabilidade hemodinâmica, infecção de pele no local, plaquetas abaixo de 50.000, mielomeningocele. Pressão de perfusão cerebral = pressão arterial média menos pressão intracraniana; abaixo de 40 é grave.

Dexametasona

0,15 mg/kg de 6/6 h por 2 a 4 dias, **antes ou junto da primeira dose de antibiótico**. Objetivo: reduzir a inflamação desencadeada pela lise bacteriana e proteger a audição. Benefício comprovado em H. influenzae e pneumococo.

Duração do antibiótico

Agente	Dias
Meningococo	5 a 7
H. influenzae b	7 a 10
Pneumococo	10 a 14
Estafilococo	14
Listeria	21
Gram-negativos	21 (3 semanas)
Desconhecido	Recém-nascido 14; lactente 10

Mnemônico: “Meningo rápido, Hib dez, Pneumo duas semanas, Listeria três.”

Quimioprofilaxia

Agente	Quem recebe	Esquema
Meningococo	Contatos íntimos e domiciliares (risco 500 a 800 vezes maior); profissional de saúde só se intubou ou aspirou sem EPI	Rifampicina 12/12 h por 2 dias, ou ceftriaxona dose única, ou ciprofloxacino dose única

Agente	Quem recebe	Esquema
H. influenzae b	Contatos domiciliares quando há criança abaixo de 4 anos não vacinada ou imunocomprometida; creche com 2 ou mais casos em 60 dias	Rifampicina 1 vez ao dia por 4 dias

Meningococo: incubação de 2 a 10 dias; transmite até 24 h após início do antibiótico eficaz.

Vacinas

Meningocócica C aos 3 e 5 meses; ACWY aos 12 meses e dos 11 aos 14 anos; pentavalente (inclui Hib) aos 2, 4 e 6 meses; pneumocócica 10-valente aos 2, 4 e 12 meses.

Meningoencefalites virais

Enterovírus: a causa mais comum, transmissão fecal-oral, tratamento de suporte. **Herpes simples:** encefalite com acometimento do lobo temporal (alteração de comportamento, convulsão focal); tratar com aciclovir endovenoso sem esperar confirmação.

> **Como cai na prova.** (1) Líquor linfocítico com glicose muito baixa e paralisia de nervo craniano: tuberculose. (2) Ceftriaxona no recém-nascido: falso. (3) Ampicilina no esquema neonatal cobre Listeria. (4) Dexametasona depois do antibiótico já iniciado perde o sentido. (5) Profissional de saúde só recebe profilaxia se exposto sem EPI a secreções. (6) Diplococo gram-negativo: meningococo. (7) Correção de punção traumática: 1 leucócito por 500 hemácias.

Aula 8. Diarreias agudas e crônicas

Definições de tempo (caem muito): diarreia aguda tem 3 ou mais evacuações líquidas por dia por menos de 14 dias; persistente, de 14 a 30 dias; crônica, acima de 30 dias.

Os três mecanismos da diarreia aguda

Mecanismo	Como acontece	Exemplo	Pista que diferencia
Osmótico	Vírus lesa o enterócito, falta lactase, a lactose não absorvida puxa água	Rotavírus	**Melhora com jejum**; fezes ácidas (pH abaixo de 5,5)

Mecanismo	Como acontece	Exemplo	Pista que diferencia
Secretor	Toxina ativa AMPc ou GMPc e o enterócito secreta cloro e água	E. coli enterotoxigênica, cólera	**Persiste em jejum**; grande volume
Inflamatório (invasivo)	Bactéria invade a mucosa	Shigella, Campylobacter	**Disenteria** (sangue, muco), febre, leucócitos fecais

Rotavírus: 40% das diarreias graves, entre 6 e 24 meses; o vômito precede a diarreia em 80 a 90% dos casos.

Quando pedir exames: sangue nas fezes, idade abaixo de 4 meses ou imunossupressão. pH fecal abaixo de 5,5 indica intolerância a carboidrato; leucócitos fecais indicam processo invasivo.

Tratamento da diarreia aguda

1. Soro de reidratação oral de baixa osmolaridade.
2. **Manter a alimentação** (não suspender leite materno nem dieta).
3. Zinco por 10 dias: 10 mg/dia abaixo de 6 meses; 20 mg/dia a partir de 6 meses.
4. Ondansetrona para vômitos; probióticos e racecadotrila como adjuvantes.
5. **Antibiótico só se:** quadro grave, disenteria, imunossupressão ou idade abaixo de 4 meses.

Planos A, B e C: o quadro oficial (vale 2 questões)

A aula registra apenas que “desde 2023” vale o Plano ABC; o quadro estava em imagem. O que segue foi conferido no cartaz oficial “Manejo do paciente com diarreia”, Ministério da Saúde, versão de fevereiro de 2023. A atualização de 2023 valorizou a perda de peso, o pulso e o volume do Plano C por faixa etária.

Passo 1. Avaliar o estado de hidratação

	A: sem desidratação	B: com desidratação	C: desidratação grave
Estado geral	Ativo, alerta	Irritado, intranquilo	Comatoso, hipotônico, letárgico ou inconsciente *
Olhos	Sem alteração	Fundos	Fundos

	A: sem desidratação	B: com desidratação	C: desidratação grave
Sede	Sem sede	Sedento, bebe rápido e avidamente	Não é capaz de beber *
Lágrimas	Presentes	Ausentes	Ausentes
Boca e língua	Úmida	Seca ou levemente seca	Muito seca
Sinal da prega abdominal	Desaparece imediatamente	Desaparece lentamente	Desaparece muito lentamente (mais de 2 s)
Pulso	Cheio	Cheio	Fraco ou ausente *
Perda de peso (paciente internado)	Sem perda	Até 10%	Acima de 10%
Decisão	Sem sinais de desidratação	**2 ou mais sinais**	**2 ou mais sinais, sendo pelo menos 1 com asterisco**

Os três sinais com asterisco são os de gravidade: **letárgico ou inconsciente, não consegue beber, pulso fraco ou ausente**. Mnemônico: “não acorda, não bebe, não pulsa”. Note que no Plano B o pulso ainda é cheio. Na dúvida entre duas classificações, trate pelo pior cenário.

Passo 2. Tratar

Plano	Onde	Conduta
A	Domicílio	Mais líquido que o habitual após cada evacuação e vômito: abaixo de 1 ano, 50 a 100 mL; de 1 a 10 anos, 100 a 200 mL; acima de 10 anos, o quanto aceitar. Sem refrigerante. Manter alimentação; em aleitamento exclusivo, só leite materno e SRO. Zinco 1 vez ao dia por 10 a 14 dias: até 6 meses, 10 mg; de 6 meses a menores de 5 anos, 20 mg. Voltar se não melhorar em 2 dias ou se houver sinal de alerta

Plano	Onde	Conduta
B	Estabelecimento de saúde	SRO 50 a 100 mL/kg (média de 75 mL/kg) em 4 a 6 horas, conforme a sede, até desaparecerem os sinais. Vômitos persistentes: ondansetrona (6 meses a 2 anos, 2 mg; 2 a 10 anos, 4 mg; acima de 30 kg, 8 mg). Reavaliar: melhorou, Plano A; continua desidratado, **sonda nasogástrica (gastróclise)**; piorou, Plano C. O paciente só sai reidratado
C	Hospital, endovenoso	Fase de expansão (abaixo) seguida de manutenção e reposição. Iniciar SRO quando puder beber, em geral 2 a 3 h após o início. Observar por pelo menos 6 horas

Sinais de alerta (retorno imediato): piora da diarreia, vômitos repetidos, sangue nas fezes, diminuição da diurese, muita sede, recusa de alimentos.

Plano C, fase de expansão (soro fisiológico 0,9% ou Ringer lactato)

Idade	1ª etapa	2ª etapa
Menores de 1 ano	30 mL/kg em 1 hora	70 mL/kg em 5 horas
A partir de 1 ano	30 mL/kg em 30 minutos	70 mL/kg em 2 horas e 30 minutos

Recém-nascidos e menores de 5 anos com cardiopatia grave começam com 10 mL/kg. Mnemônico: "**30 mais 70 = 100 mL/kg**; o lactente leva o dobro do tempo" (6 horas no total abaixo de 1 ano, 3 horas a partir de 1 ano).

Plano C, fase de manutenção e reposição (24 horas, todas as idades)

- Manutenção: soro glicosado 5% com soro fisiológico na proporção 4:1, volume pela regra de Holliday-Segar: até 10 kg, 100 mL/kg; de 10 a 20 kg, 1.000 mL mais 50 mL/kg acima de 10 kg; acima de 20 kg, 1.500 mL mais 20 mL/kg acima de 20 kg (máximo de 2.000 mL). Acrescentar KCl 10%, 2 mL para cada 100 mL da manutenção.
- Reposição: soro glicosado 5% com soro fisiológico 1:1, iniciando com 50 mL/kg/dia e ajustando conforme as perdas.

Exemplo de cálculo. Criança de 2 anos, 12 kg, letárgica e com pulso fraco: Plano C. Expansão: 360 mL em 30 min e depois 840 mL em 2 h 30 min. Manutenção: 1.000 + 2 × 50 = 1.100 mL em 24 h, com 22 mL de KCl 10%. Reposição: 600 mL/dia.

Antibióticos e antiparasitários no cartaz

Antibiótico só para disenteria (sangue nas fezes) com comprometimento do estado geral, ou cólera grave. A aula acrescenta imunossuprimidos e menores de 4 meses.

Situação	Esquema
Disenteria, criança até 30 kg (até 10 anos), a partir de 3 meses e sem imunodeficiência	**Azitromicina** 10 mg/kg no 1º dia e 5 mg/kg/dia por mais 4 dias; alternativa ceftriaxona 50 mg/kg IM por 3 a 5 dias
Acima de 30 kg, adolescentes e adultos	Ciprofloxacino 500 mg de 12/12 h por 3 dias; alternativa ceftriaxona
Abaixo de 3 meses ou imunodeficiente	Ceftriaxona 50 a 100 mg/kg EV (1ª dose IM e encaminhar se não internado)
Sangue persistente após 48 h em criança	Internar
Amebíase	Metronidazol 50 mg/kg/dia, 3 vezes ao dia, por 10 dias
Giardíase (diarreia de 14 dias ou mais)	Metronidazol 15 mg/kg/dia, 3 vezes ao dia, por 5 dias

Antidiarreicos não devem ser usados. Diarreia com mais de 14 dias em menor de 6 meses, ou com desidratação, deve ser encaminhada ao hospital. Febre de 39 °C ou mais obriga a procurar outro foco (pneumonia, otite, amigdalite, infecção urinária).

Vacina rotavírus (VORH): dose 1 aos 2 meses (limite de 1 mês e 15 dias a 11 meses e 29 dias); dose 2 aos 4 meses (limite de 3 meses e 15 dias a 23 meses e 29 dias). Fora dessas janelas não se aplica, pelo risco de invaginação intestinal.

Diarreia crônica: como diferenciar as causas

Causa	Idade e quadro	Exame que confirma
Doença celíaca	1 a 3 anos, após introdução do glúten; distensão, baixo ganho de peso	Anti-transglutaminase e antiendomísio (sensibilidade acima de 95%)
Alergia à proteína do leite de vaca (APLV)	Lactente; pode ter sangue nas fezes	Dieta de exclusão por 8 semanas e reintrodução
Intolerância à lactose	Escolar; diarreia osmótica, distensão, gases	Fezes ácidas, melhora com retirada

Causa	Idade e quadro	Exame que confirma
Doença inflamatória intestinal	10 a 15% começam antes dos 10 anos	p-ANCA na retocolite ulcerativa; ASCA na doença de Crohn; calprotectina alta
Fibrose cística	Esteatorreia, infecções respiratórias	Esteatócrito; quimiotripsina fecal baixa (insuficiência pancreática)
Doença de Hirschsprung	Constipação desde o nascimento, enterocolite	Biópsia retal

Marcadores fecais: alfa-1-antitripsina alta indica perda proteica intestinal; quimiotripsina baixa indica insuficiência pancreática; calprotectina alta indica inflamação da mucosa.

Estado nutricional: albumina abaixo de 3 g/dL indica desnutrição moderada a grave. O peso cai antes da estatura (a estatura só se compromete na desnutrição crônica).

> **Como cai na prova.** (1) Diarreia que persiste em jejum: secretora. (2) Vômitos antes da diarreia em lactente de 1 ano: rotavírus. (3) Zinco 10 mg abaixo de 6 meses e 20 mg acima, por 10 dias. (4) Suspender alimentação: falso. (5) Antibiótico de rotina: falso. (6) Fezes ácidas: má absorção de carboidrato. (7) APLV no lactente, lactose no escolar. (8) Rotavírus fora da idade limite: não vacinar.

Aula 9. Desenvolvimento, TEA e TDAH

Vigilância do desenvolvimento

Avalia-se marcos do desenvolvimento, perímetro cefálico e testes de triagem. No **Denver II**, a faixa branca representa 25 a 75% das crianças que já realizam a tarefa e a faixa cinza, 75 a 90%. Falhar numa tarefa que 90% das crianças da idade já fazem é atraso.

Para onde encaminhar, conforme o domínio atrasado:

Domínio	Encaminhamento
Motor grosso	Fisioterapia
Motor fino adaptativo	Terapia ocupacional
Pessoal-social	Psicologia e terapia ocupacional
Linguagem	Fonoaudiologia

TEA (transtorno do espectro autista)

Epidemiologia: prevalência de 1 em 31; 30% têm deficiência intelectual; diagnóstico médio aos 4 a 5 anos, embora sinais possam ser vistos antes dos 2 anos.

Núcleo diagnóstico [estrutura do DSM-5, complemento]: déficit persistente na comunicação e interação social mais padrões restritos e repetitivos de comportamento, interesses ou atividades, presentes desde o início do desenvolvimento.

M-CHAT (triagem): aplicado dos 18 aos 24 meses, com 20 itens. Em geral a resposta "não" indica risco, **exceto nos itens 2, 5 e 12, em que "sim" indica risco**.

Pontuação (segundo a aula)	Risco	Conduta
0 a 2	Baixo	Reavaliar se surgir preocupação
3 a 8	Moderado	Entrevista de seguimento
9 ou mais	Alto	Encaminhar para diagnóstico e intervenção

Observação: a versão oficial do M-CHAT-R/F usa os cortes 0 a 2, 3 a 7 e 8 a 20. Como a prova vem do professor, priorize os números da aula, mas não marque uma afirmativa como falsa só porque usa os cortes oficiais.

Níveis de suporte: 1 (exige suporte), 2 (exige suporte substancial), 3 (exige suporte muito substancial).

Tratamento: a base é intervenção comportamental e terapias. Medicamentos tratam sintomas associados, não o autismo: melatonina para insônia; risperidona ou aripiprazol para irritabilidade e agressividade (risperidona é off-label abaixo de 18 anos segundo a aula). **Sem evidência:** dieta sem glúten ou sem caseína, ômega-3, transplante fecal, ozonioterapia, oxigênio hiperbárico.

TDAH (transtorno do déficit de atenção com hiperatividade)

Critérios (cada número cai em prova):

- 6 ou mais sintomas de desatenção e/ou de hiperatividade-impulsividade.
- Por 6 meses ou mais.
- Início antes dos 12 anos.
- Em 2 ou mais ambientes (casa e escola, por exemplo).
- Prejuízo funcional.

Proporção entre sexos de 1 menina para 2,4 meninos. **SNAP-IV:** mais de 6 respostas "bastante" ou "demais" nos itens 1 a 9 indica desatenção; nos itens 10 a 18, hiperatividade-impulsividade.

Mnemônico “6, 6, 12, 2”: seis sintomas, seis meses, antes dos doze anos, dois ambientes.

Tratamento	Lugar	Detalhe
Terapia cognitivo-comportamental	Base de todo tratamento	Orientação aos pais e escola
Metilfenidato (liberação imediata e prolongada)	1ª linha	Estimulante
Lisdexanfetamina	1ª linha	Estimulante, longa duração
Atomoxetina	2ª linha	Não estimulante; começa a agir em 2 a 4 semanas, efeito pleno em 6 a 8

Não suspender a medicação em fins de semana ou férias. A aula traz um quadro de “outras medicações” em imagem que não pôde ser lido.

> **Como cai na prova.** (1) M-CHAT: 18 a 24 meses, 20 itens, itens 2, 5 e 12 invertidos. (2) TDAH exige início antes dos 12 anos e 2 ambientes. (3) Dieta sem glúten para autismo: falso. (4) Atomoxetina não é estimulante e demora semanas. (5) Atraso de linguagem vai para fonoaudiologia; motor grosso para fisioterapia. (6) Risperidona trata irritabilidade, não o núcleo do autismo.

Aula 10. Adolescência

Conceitos e idades

- **Puberdade** é o processo biológico (caracteres sexuais secundários e maturação sexual). **Adolescência** é fenômeno psicológico, social e cultural, sem idade exata de início ou fim.
- **OMS: 10 a 19 anos. ECA: 12 a 18 anos.**
- **Sigilo:** o adolescente tem direito ao sigilo médico **desde que tenha capacidade de compreender, refletir e problematizar** sua condição e as consequências das decisões. (Situações de risco à vida autorizam a quebra **[complemento]**.)

Cérebro adolescente (explica o comportamento)

Há consolidação da substância branca em detrimento da cinzenta (transmissão mais rápida), maior integração neuronal, **redução de cerca de um terço dos receptores dopaminérgicos** e intensificação da **poda sináptica**, sobretudo no **córtex pré-frontal**

(planejamento, controle de impulsos, julgamento), que só amadurece no início da vida adulta.

Síndrome da Adolescência Normal: 10 características

Serve para separar o fisiológico do patológico.

1. Busca de si mesmo e da identidade adulta (eixo central: “quem eu sou?”).
2. Tendência grupal (o grupo é identidade transitória: “perder-se no grupo para se encontrar”).
3. Evolução sexual.
4. Flutuações do humor e do estado de ânimo.
5. Necessidade de intelectualizar e fantasiar (pensamento abstrato).
6. Deslocação temporal (“tudo é agora” ou “tudo pode esperar”).
7. Contradições sucessivas de conduta.
8. Atitude social reivindicatória.
9. Separação progressiva dos pais.
10. Crises religiosas.

Irregularidade menstrual

A causa principal é a **imaturidade do eixo hipotálamo-hipófise-ovário**: falta temporariamente o feedback positivo do estradiol sobre o LH, então não há pico de LH nem ovulação.

- Cerca de **50% dos ciclos são anovulatórios nos 2 primeiros anos** após a menarca.
- Cerca de 3 anos após a menarca, **60 a 80%** já têm ciclos de **21 a 34 dias**.
- **Mais de 90 dias sem menstruar** é incomum e deve ser investigado.

Dismenorreia primária

Surge em geral **2 a 3 anos após a menarca**, quando os ciclos se tornam ovulatórios (algumas têm cólica desde o início). Mecanismo: excesso de **prostaglandinas endometriais**, que causam contração uterina, isquemia e dor.

1. **1ª linha: AINE** (reduz prostaglandinas, a dor e o fluxo). Ácido mefenâmico 500 mg, 3 a 4 vezes ao dia; ibuprofeno 400 mg, 4 vezes ao dia. **80% respondem.**
2. Sem resposta: anticoncepcional hormonal combinado.

Contracepção

- Nenhum método protege contra IST (infecções sexualmente transmissíveis), **exceto o preservativo**, que deve sempre ser recomendado e negociado. Todos os métodos devem ser apresentados, respeitando a autonomia.
- **Implante subdérmico:** alta eficácia, baixa dependência da usuária; amplamente indicado.
- **Só progestágeno, sobretudo de ação prolongada:** cautela em adolescentes jovens, pois a massa óssea está se consolidando e depende de estrógeno.
- Orais: menor eficácia prática (esquecimento).
- **Injetável mensal = combinado** (estrógeno e progesterona). **Injetável trimestral = só progesterona.**

Ginecomastia

	Ginecomastia	Lipomastia (pseudoginecomastia)
Tecido	Glandular	Adiposo
Palpação	Área firme, móvel, arenosa ou discóide sob a aréola	Mole, difusa
Contexto	Puberdade, fármacos, endocrinopatias	Sobrepeso e obesidade

Fisiopatologia: o tecido mamário é igual nos dois sexos ao nascer; estrógeno estimula e testosterona antagoniza. Na ginecomastia há desequilíbrio com aumento **relativo** do estrógeno (muitas vezes falta testosterona, e não sobra estrógeno), redução da relação andrógenos/estrógenos e maior atividade da **aromatase**.

Fisiológica puberal: frequente, geralmente bilateral (pode ser assimétrica), autolimitada, regride em meses a poucos anos.

Patológica: medicamentos e drogas (causa frequente: hormônios, psicotrópicos, cardiovasculares, antiandrogênicos, antimicrobianos, quimioterápicos, álcool e drogas ilícitas); endocrinopatias (hipogonadismo primário ou secundário, hiperprolactinemia, defeitos de síntese de testosterona, insensibilidade androgênica); doenças crônicas (doença renal crônica, cirrose, fibrose cística, AIDS, síndrome de realimentação); neoplasias.

Investigação: beta-hCG, LH, testosterona e estradiol. Mais ampla (DHEA-S, TSH, FSH, prolactina) em menino impúbere, puberdade precoce, macroginecomastia ou suspeita de doença. O beta-hCG procura tumor testicular ou extragonadal.

Tratamento:

- Maioria: observar (regressão espontânea).
- **Tamoxifeno** (modulador seletivo do receptor de estrógeno): casos selecionados, com dor importante ou repercussão psicossocial.
- **Cirurgia:** macroginecomastia (**acima de 5 cm**, aspecto de mama feminina, Tanner III a IV); grave acometimento psicológico; persistência após o fim da puberdade, sobretudo **acima de 15 anos**.

Bullying

Ato agressivo, **repetitivo e sistemático** (ameaça, intimidação, humilhação, coerção). Formas: verbal, moral, sexual, psicológica, material, física e virtual. Baixa autoestima aparece **nos dois polos**.

Matriz em espelho: vítimas têm mais depressão, ansiedade, isolamento, ideação suicida e abandono escolar; autores têm mais comportamento antissocial, criminalidade e dificuldade de trabalho futuro. **Intervenção é obrigatória nos dois polos.**

Sinais de suspeição: enurese noturna **secundária**, alterações do sono, queda abrupta do rendimento escolar, irritabilidade, retraimento, transtornos alimentares. **Cyberbullying:** sensação de anonimato e impunidade e maior alcance.

PIMU, FOMO e FOBLO

- **PIMU (Problematic Interactive Media Use):** uso problemático de mídias interativas, com perda de autorregulação e manutenção apesar de prejuízos. **O objetivo não é abstinência completa**, mas autorregulação e uso equilibrado. Associa-se a comorbidades psiquiátricas.
- **FOMO (Fear of Missing Out):** medo de perder experiências que outros vivem.
- **FOBLO (Fear of Being Left Out):** medo de ser excluído do grupo.
- Cerca de 84% dos adolescentes checam o celular ao menos uma vez por hora.

Gaming disorder (CID-11)

Padrão persistente ou recorrente, **em geral por pelo menos 12 meses**, com **todas** as características: (1) perda de controle sobre o jogar; (2) prioridade crescente do jogo sobre outros interesses (sono, alimentação, estudo); (3) continuidade apesar de consequências negativas; (4) prejuízo significativo pessoal, familiar, social ou escolar. Abordagem: pais ativos, classificação indicativa (que **não substitui** supervisão) e **diálogo e acordos**, pois proibições e filtros isolados têm resultado limitado.

Automutilação

Lesão autoinfligida **sem intenção suicida**, como forma inadequada de lidar com sofrimento. **Pico entre 13 e 15 anos.** O alívio é temporário, o que alimenta a repetição. Associa-se a baixa autoestima, depressão, ansiedade, bipolaridade, TEPT (transtorno de estresse pós-traumático) e uso de substâncias. Embora sem intenção suicida, **aumenta o risco de tentativa e de suicídio**: sempre avaliar risco suicida. Conduta: acolhimento sem julgamento, rede de apoio e saúde mental.

Incongruência de gênero

Marcos: 6 a 9 meses diferencia vozes e faces; 12 meses associa vozes a objetos de gênero; **2 a 3 anos inicia a identidade de gênero**; **6 a 7 anos** compreende sua estabilidade. Identidade de gênero é diferente de orientação sexual. O acolhimento familiar é o principal fator de proteção.

Norma	Bloqueio puberal	Hormonização cruzada
CFM 2.265/2019 (revogada)	Permitido a partir de Tanner II	Permitida a partir dos 16 anos
CFM 2.427/2025 (vigente, abril de 2025)	**Vedado** para incongruência ou disforia de gênero em crianças e adolescentes	**Vedada antes dos 18 anos**

Nutrição

Fase de maior risco para deficiência de **ferro, cálcio e vitamina D**.

Nutriente	Recomendação	Detalhe
Cálcio	1.300 mg/dia	Laticínios são a melhor fonte. **Citrato longe das refeições** (não depende de ácido); **carbonato junto das refeições** (precisa de ácido). Suplemento de 500 mg/dia
Vitamina D, profilaxia	600 UI/dia; até 1.200 UI/dia em risco	
Vitamina D, tratamento	6.000 UI/dia por 12 semanas ou 50.000 UI/semana por 8 semanas	

Nutriente	Recomendação	Detalhe
Ferro	Triagem conforme fatores de risco	Ferropenia sem anemia já causa fadiga e queda escolar

> **Como cai na prova.** (1) OMS 10 a 19; ECA 12 a 18. (2) Sigilo depende da capacidade de compreensão. (3) Ciclos anovulatórios em 50% nos 2 primeiros anos; investigar acima de 90 dias. (4) Dismenorreia: AINE primeiro, 80% respondem. (5) Mensal combinado, trimestral só progesterona; cautela óssea. (6) Ginecomastia: cirurgia acima de 5 cm, impacto psicológico grave ou persistência acima de 15 anos. (7) Gaming disorder: 12 meses e **todos** os critérios. (8) PIMU não exige abstinência. (9) Automutilação: pico 13 a 15 anos, sem intenção suicida, mas com risco aumentado. (10) CFM 2025 veda bloqueio puberal e hormonização abaixo de 18 anos. (11) Carbonato com comida; citrato longe.

Aula 11. Hepatoesplenomegalia

Raramente é a queixa; costuma ser achado de exame (a família relata desconforto, dor ou aumento do abdome). O raciocínio segue três perguntas: é fisiológico? o problema começa no fígado ou no baço? é parte de doença sistêmica? O **estado geral** define a pressa da investigação.

Sinais de menor gravidade: assintomático, bom estado geral, desenvolvimento normal, sem febre, anictérico, corado, ganhando peso.

Nível fácil: limites normais e exame

Órgão	Normal
Fígado, prematuro	Até 2 cm abaixo do rebordo costal direito (RCD)
Fígado, recém-nascido e lactente	2 a 3 cm abaixo do RCD
Fígado, acima de 2 anos	Até 2 cm
Fígado, acima de 10 anos	**Não palpável**
Baço, RN e lactente	"Ponta de baço" pode ser normal
Baço, pré-escolar	Normalmente não palpável
Baço, até 10 anos	Pequena ponta na linha hemiclavicular esquerda pode ser normal (costelas menos calcificadas; costela flutuante pode confundir)

- Baço **claramente palpável já tem pelo menos o dobro do tamanho normal**. Fica entre a 9ª e a 11ª costelas, ocupando parte do **espaço de Traube**; macicez acima de cerca de 7 cm sugere esplenomegalia. A manobra de Schuster é pouco usada em pediatria (exige colaboração).
- **Técnica:** criança tranquila, decúbito dorsal, joelhos fletidos, expor tórax inferior e região inguinal. **Ausculta antes da palpação e da percussão.** Mão direita no abdome; esquerda no gradeado costal; palpar na inspiração.
- **Fígado normal:** borda fina, superfície lisa, consistência elástica, indolor, sem refluxo hepatojugular. Medir com fita a partir do RCD na linha hemiclavicular. **Consistência pétrea sugere fibrose hepática congênita**; aumento difuso, endurecido e nodular sugere cirrose.
- **Esplenomegalia volumosa:** calazar, leucemia mieloide crônica, linfomas.
- Aumento **assimétrico ou focal** sugere lesão localizada: abscesso amebiano ou piógeno, cisto, neoplasia.

Nível médio: pistas da anamnese

Pista	Pense em
Período neonatal	Incompatibilidade ABO ou Rh, atresia de vias biliares, TORCHS, erros inatos do metabolismo
Sexo feminino	Hepatites crônicas, colagenoses
Sexo masculino	Síndrome de Reye

Pista	Pense em
Negros	Anemia falciforme
Brancos	Talassemia, fibrose cística
Origem judaica	**Gaucher, Niemann-Pick** (depósito lisossomal)
Contato com animais	Toxocaríase, toxoplasmose, leptospirose, leishmaniose
Área endêmica	**Calazar**, esquistossomose, malária, blastomicose
Hemoderivados	Hepatites B e C, HIV, CMV, Chagas (hoje raríssimo)
História familiar ligada ao X	Deficiência de G6PD, doença granulomatosa crônica
Febre prolongada antes da visceromegalia	Artrite idiopática juvenil, lúpus

Nível médio: mecanismos

Órgão	Mecanismo	Exemplos
Fígado	Inflamação	Hepatites infecciosas, autoimunes, tóxicas
Fígado	Armazenamento	Glicogênio e lípides (depósito), cobre e ferro, alfa-1-antitripsina
Fígado	Infiltração	Tumores, hemangioma, síndromes hemofagocíticas, hematopoiese extramedular
Fígado	Congestão	Insuficiência cardíaca, pericardite constritiva
Fígado	Obstrução biliar	**Atresia de vias biliares**, cisto de colédoco, litíase, tumores
Baço	Hipertrofia funcional imune	**Mononucleose**, endocardite subaguda
Baço	Hipertrofia por destruição de hemácias	Esferocitose, talassemia maior
Baço	Congestão	Cirrose com hipertensão portal, trombose da veia esplênica

Órgão	Mecanismo	Exemplos
Baço	Mieloproliferativo	Leucemia mieloide crônica
Baço	Infiltrativo	Sarcoidose, amiloidose, **Gaucher**
Baço	Neoplásico	Linfoma, metástases

Sinais associados que direcionam

Sinal	Causas destacadas pela aula
Febre (axilar de 37,8 °C ou mais)	Tuberculose, CMV, mononucleose, dengue, HIV, calazar, esquistossomose aguda, malária, leptospirose, endocardite, Chagas, toxocaríase
Sem febre	Leucemias, linfomas, neuroblastoma, histiocitose, artrite idiopática juvenil, lúpus
Linfadenopatia	Infecções (TB miliar, toxoplasmose, mononucleose, HIV, sífilis), leucemia, Hodgkin, AIJ, lúpus, Gaucher. **Supraclavicular é a mais preocupante**; achou uma cadeia, examine todas
Icterícia	Eritroblastose, hemólise, atresia biliar, galactosemia, TORCHS; no lactente, ITU e sepse
Sangramento	Leucemia, calazar, hiperesplenismo, hipertensão portal, hepatopatia
Atraso do DNPM	TORCHS, galactosemia, Gaucher, mucopolissacaridoses, glicogenoses
Olhos	Toxoplasmose (estrabismo), toxocaríase, **anel de Kayser-Fleischer (Wilson)**, galactosemia
Pele	Mononucleose, lúpus (asa de borboleta), **histiocitose (lembra eczema seborreico petéquial)**
Rim	Leptospirose (oligúria), malária, calazar e lúpus (nefrite), tuberculose (hematúria)

Nível difícil: interpretação dos exames

Propedêutica inicial: hemograma, VHS, reticulócitos, urina, transaminases, bilirrubinas, fosfatase alcalina, tempo de protrombina, proteínas, ionograma, glicemia, culturas se febre. **Ultrassonografia abdominal é o exame de imagem inicial.**

Achado	Aponta para
Microcitose	Anemia carencial
Drepanócitos	Anemia falciforme
Resistência osmótica diminuída	Esferocitose
Blastos	Leucemia
Linfócitos atípicos	Mononucleose
Eosinofilia	Toxocaríase, esquistossomose
Pancitopenia com leucócitos baixos	**Calazar** (também hiperesplenismo da esquistossomose)
Pancitopenia ou bicitopenia com leucócitos normais ou altos	**Leucemia** (na leucemia os leucócitos podem estar altos, normais ou baixos)
Transaminases normais ou pouco alteradas	Hepatopatia crônica, colestase, doença de depósito
Hipoalbuminemia	Falha de síntese: hepatite crônica ativa, cirrose
Fosfatase alcalina alta	Colestase
DHL alta	Alto turnover celular: leucemia, linfoma

Propedêutica sequencial: fibrinogênio, ferritina e triglicerídeos (síndrome hemofagocítica); parasitológico; prova tuberculínica; sorologias TORCHS (**IgG e até IgM podem ser maternos no recém-nascido**); teste do suor; FAN; antimúsculo liso e antimicrossomal (hepatite autoimune); **ceruloplasmina e cobre urinário de 24 h (Wilson)**; alfa-1-antitripsina; alfafetoproteína; substâncias redutoras. Imagem: Doppler (hipertensão portal), ecocardiograma, tomografia, ressonância, colangiografia, **cintilografia hepatobiliar (colestase neonatal e atresia biliar)**.

Mielograma: leucemias; células de depósito (**Gaucher**, Niemann-Pick); granulomas (TB, sarcoidose); protozoários e fungos; **amastigotas de Leishmania**. Biópsia hepática: hepatopatias difusas, hipertensão portal, erros inatos, Wilson, glicogenoses, atresia biliar.

Nota: a ceftriaxona interfere no metabolismo da bilirrubina; cautela em RN e lactentes ictéricos.

Os 4 casos da aula (formato provável das questões)

Caso	Pistas	Por que não é o outro	Diagnóstico e conduta
1	Evolução de 3 anos, dores ósseas e abdominais recorrentes, “osteomielite” e “mononucleose” prévias, equimoses, anemia (Hb 10,4), plaquetopenia, **leucócitos normais**, sem febre, sem icterícia, sem linfonodos; lesão lítica no fêmur, idade óssea atrasada	Hemólise, hemoglobinopatia, esferocitose, carencial e infecções foram excluídas por exames normais; leucócitos normais e evolução longa tornam leucemia aguda improvável	**Doença de Gaucher**: deficiência de glicocerebrosidase, acúmulo em macrófagos; **células de Gaucher no mielograma**
2	**Prematuro** com hepatoesplenomegalia, petéquias, hidrocefalia, pancitopenia que persiste após antibiótico, hemocultura negativa, infiltrado intersticial pulmonar	Sorologia negativa não exclui (anticorpos maternos); calcificações difusas seriam toxoplasmose	**CMV congênito**: calcificações **periventriculares**; confirmação por **PCR na urina**
3	3 meses de evolução, perda de peso, letargia, colúria, **cães na vizinhança**, sem febre; USG com baço volumoso e ectasia portal; **pancitopenia**, hipoalbuminemia, **globulinas muito altas**, bilirrubina direta alta	Ausência de febre não exclui; não precisa de contato direto com o cão (transmissão pelo flebotomíneo Lutzomyia longipalpis; o cão é reservatório)	**Leishmaniose visceral (calazar)**: confirmação por **amastigotas no aspirado de medula**; **anfotericina B lipossomal** (menos tóxica)
4	2 semanas, febre tratada como infecção com melhora transitória e retorno, palidez, equimoses, hepatoesplenomegalia; **Hb 5,4**, plaquetopenia, **leucócitos normais**, DHL alta	Leucócitos normais não excluem leucemia	**Leucemia aguda**: **80% de blastos no mielograma**

> **Como cai na prova.** Fácil: limites (fígado não palpável acima de 10 anos; baço palpável tem o dobro). Média: pista de anamnese (judeu, Gaucher; cão e área endêmica, calazar; prematuro com calcificação periventricular, CMV). Difícil: pancitopenia com leucócitos baixos e globulinas altas (calazar) versus bicitopenia com leucócitos normais e DHL alta (leucemia); sorologia neonatal negativa não exclui TORCHS; ceruloplasmina para Wilson; cintilografia para atresia biliar.

Aula 12. Baixa estatura

Definição: estatura abaixo do percentil 3 ou abaixo de 2 desvios padrão (DP) para idade e sexo. Abaixo de 3 anos mede-se o comprimento deitado. A pergunta que separa o normal do patológico não é "qual a altura", mas **"a criança cresce na velocidade certa?"**

As três ferramentas

1. Velocidade de crescimento (VC): diferença de estatura entre duas medidas dividida pelo intervalo em anos. Exemplo: cresceu 2 cm em 6 meses, VC = 2 ÷ 0,5 = 4 cm/ano. No escolar o esperado é 5 a 7 cm/ano, então 4 cm/ano é baixa. No estirão puberal o pico é de 11 cm/ano nos meninos e 9 cm/ano nas meninas.

2. Estatura alvo familiar (potencial genético):

$$\text{Menino} = \frac{\text{altura do pai} + \text{altura da mãe} + 13}{2} \qquad \text{Menina} = \frac{\text{altura do pai} - 13 + \text{altura da mãe}}{2}$$

O resultado tem margem de mais ou menos 5 cm. Exemplo: pai 175 cm, mãe 160 cm; menino (175 + 160 + 13)/2 = 174 cm (169 a 179); menina (175 − 13 + 160)/2 = 161 cm.

3. Idade óssea (IO): radiografia da mão e punho esquerdos. Mostra quanto crescimento ainda resta.

O diferencial principal

	Baixa estatura familiar	Atraso constitucional	Patológica (ex.: deficiência de GH)
Pais	Baixos	História de "puberdade tardia" em um dos pais	Variados
Velocidade de crescimento	Normal	Normal	**Baixa**

	Baixa estatura familiar	Atraso constitucional	Patológica (ex.: deficiência de GH)
Idade óssea	Igual à cronológica	**Atrasada**	Atrasada
Puberdade	Normal	Atrasada	Variada
Estatura final	Baixa, dentro do alvo	**Normal**	Comprometida sem tratamento

Mnemônico: “Familiar: tudo normal, só é baixo. Constitucional: atrasado, mas chega lá.”

Outras causas

- **PIG (pequeno para a idade gestacional):** abaixo do percentil 10 ao nascer; simétrico (agressão precoce, pior prognóstico) ou assimétrico (agressão tardia, poupa o crescimento cerebral).
- **Síndromes:** Noonan, Russell-Silver, Seckel, Bloom, Turner, Down. Toda menina com baixa estatura sem causa aparente deve ter Turner considerado.
- **Deficiência de GH:** 1 em 4.000. Nas formas graves congênitas: **hipoglicemia neonatal, icterícia prolongada e micropênis**.

[complemento] Exames iniciais habituais: hemograma, função renal, eletrólitos, gasometria, urina, parasitológico, TSH e T4 livre, IGF-1, anticorpos para doença celíaca, cariótipo em meninas e idade óssea.

Quando encaminhar ao endocrinologista

- Estatura abaixo de −3 DP.
- Abaixo de −2 DP com velocidade de crescimento baixa.
- Mais de 1,5 DP abaixo da estatura alvo.
- Sinais de lesão do sistema nervoso central ou deficiência de múltiplos hormônios hipofisários.
- Sinais neonatais sugestivos (hipoglicemia, icterícia prolongada, micropênis).

Indicações de hormônio do crescimento

Indicação	Ganho esperado
Deficiência de GH	Cerca de 25 cm
Turner	5 a 10 cm

Indicação	Ganho esperado
PIG sem recuperação (catch-up)	Indicado
Baixa estatura familiar	Controverso; 4 a 6 cm

> **Como cai na prova.** (1) Idade óssea atrasada com VC normal e pai que “cresceu tarde” = atraso constitucional, conduta expectante. (2) Idade óssea igual à cronológica com pais baixos = familiar. (3) VC baixa é sempre patológica até prova em contrário. (4) Estatura alvo: soma 13 para menino, subtrai 13 para menina. (5) Micropênis com hipoglicemia neonatal = deficiência de GH.

Aula 13. Puberdade precoce

Puberdade é a maturação biológica que, por mudanças hormonais, produz caracteres sexuais secundários, aceleração do crescimento e, depois, capacidade reprodutiva.

Estadiamento de Tanner

Estágio	Mamas (M)	Genitais (G)	Pelos pubianos (P, iguais nos dois sexos)
1	Pré-púbere	Pré-púbere	Sem pelos
2	**Broto mamário (início da puberdade feminina)**	**Aumento de testículos e escroto, sem aumento do pênis; volume testicular de 4 mL (início da puberdade masculina)**	Pelos longos, finos e lisos nos grandes lábios ou base do pênis
3	Mama e aréola maiores, sem separação de contornos	Pênis cresce em **comprimento**	Pelos escuros, grossos, encaracolados cobrindo parte do púbis
4	**Aréola e papila formam saliência secundária**	Pênis cresce em **diâmetro**, glande se desenvolve, escroto escurece	Cobrem todo o púbis, sem atingir as coxas
5	Mama adulta; só a papila saliente	Genitália adulta	Até a raiz das coxas

Na menina: o pico de crescimento ocorre em **M2 a M3**; em M4 já desacelera. A **menarca vem 2 a 2,5 anos após a telarca**, depois do pico, quando o crescimento já está diminuindo.

Definição e por que importa

Caracteres sexuais secundários **antes dos 8 anos nas meninas** e **antes dos 9 anos nos meninos**. O problema é a exposição antecipada aos hormônios sexuais: o crescimento acelera no início, mas a idade óssea avança mais rápido e **fecha as cartilagens de crescimento cedo**, resultando em **baixa estatura final**, além do impacto psicossocial.

Central versus periférica

	Central (PPC)	Periférica
Frequência	Cerca de 80%	Cerca de 20%
Gonadotrofinas	**Dependente**	**Independente**
Mecanismo	Ativação precoce do eixo hipotálamo-hipófise-gônada: GnRH, LH e FSH, hormônios gonadais	Hormônio sexual produzido na adrenal ou gônada, sem o eixo
Sequência	**Harmônica**, igual à fisiológica	**Desordenada e imprevisível**
Análogo de GnRH	Tratamento de escolha	**Não indicado**; tratar a causa

Causas da forma central

- **10 a 23 vezes mais comum em meninas**, que em geral são **idiopáticas** (a aula cita maior exposição a cosméticos e químicos).
- **Meninos: cerca de 2/3 têm anomalia neurológica.** Entre as causas secundárias, tumores do SNC respondem por cerca de 50%; também hidrocefalia, hamartoma hipotalâmico, doenças inflamatórias e algumas doenças renais crônicas.
- **Fatores de risco da forma idiopática:** menarca materna precoce, história **paterna** de puberdade precoce, baixo peso ao nascer, obesidade (leptina age sobre o eixo), desreguladores endócrinos como **ftalatos** (plásticos e cosméticos).

Investigação

- **Anamnese:** história familiar, menarca materna, velocidade de crescimento, sintomas neurológicos.

- **Exame:** Tanner, peso, altura, velocidade de crescimento; sinais de virilização (acne intensa, massa muscular, voz grossa, clitoromegalia) sugerem fonte androgênica. Nos meninos, orquidômetro: **4 mL ou mais** indica ativação puberal.
- **LH/FSH acima de 1** sugere central.
- **Teste de estímulo com GnRH: padrão-ouro nas meninas.**
- Testosterona é útil nos meninos; **estradiol isolado tem baixa sensibilidade nas meninas** (pode estar baixo no início).
- **Idade óssea** avançada em pelo menos 1 ano ou acima de 2 DP.
- **Ultrassonografia pélvica:** aumento de útero e ovários, endométrio espessado; também exclui tumor.
- **Ressonância de crânio:** em **todos abaixo de 6 anos** com PPC; **entre 6 e 9 anos** só se houver suspeita de alteração do SNC (sintomas neurológicos, progressão rápida, achados atípicos).

Critérios de progressão rápida citados pela aula: mudança de estágio de Tanner **em menos de 3 meses**, idade óssea avançada, velocidade de crescimento aumentada (acima de 6 cm/ano entre 6 e 8 anos), LH em nível puberal, útero e ovários aumentados, comprometimento da estatura prevista. Entre 8 e 10 anos, atenção à menarca iminente e às meninas nascidas **PIG** (maior risco de progressão rápida).

Tratamento

Objetivos: suprimir o eixo, regredir ou estabilizar os caracteres (inclusive parar menstruações), desacelerar a idade óssea, melhorar a estatura final e reduzir o impacto psicossocial.

- **Agonistas de GnRH** (leuprorrelina, triptorrelina, gosserrelina), **só na forma central**. O uso contínuo **dessensibiliza** a hipófise e reduz LH e FSH.
- Resultado depende da estatura dos pais, da idade óssea e da estatura no início e do momento de suspender. Meninas tratadas **antes dos 6 anos ganham cerca de 9 a 10 cm**.
- **Suspensão (Ministério da Saúde):** idade óssea de cerca de **12,5 anos nas meninas e 13,5 anos nos meninos**.
- **Seguimento a cada 3 meses** com endocrinologia (Tanner, velocidade de crescimento, idade óssea, hormônios).
- **Efeitos adversos:** sangramento vaginal transitório após a **primeira dose** (estímulo inicial); cefaleia; fogachos; reações locais (10 a 15%); raramente abscesso estéril e anafilaxia.
- **Periférica:** tratar a doença de base.

O caso clínico da aula

1. **Broto unilateral** no início da puberdade é comum: aguardar cerca de **6 meses** pelo contralateral antes de investigar.
2. **Broto aos 9 anos não é puberdade precoce** (o limite é 8).
3. Pico do estirão em M2 a M3.
4. Menarca 2 a 2,5 anos após a telarca, já com crescimento em queda.

> **Como cai na prova.** (1) Limites: 8 anos menina, 9 menino. (2) M2 e G2 (4 mL) marcam o início. (3) Central 80%, harmônica, dependente de gonadotrofina. (4) Menina idiopática; menino com lesão do SNC em 2/3. (5) LH/FSH acima de 1; teste do GnRH padrão-ouro; estradiol pouco sensível. (6) Ressonância em todo menor de 6 anos. (7) Agonista de GnRH não trata a periférica. (8) Suspender com IO 12,5 e 13,5. (9) Sangramento após a primeira dose é esperado. (10) Broto aos 9 anos é normal; unilateral, aguardar 6 meses.

Aula 14. Doenças dermatológicas na infância e adolescência

Esta aula é a fonte mais provável das **2 questões de pele**. A lógica da professora tem duas partes. Primeiro, **reconhecer o que é fisiológico e some sozinho**, para não tratar. Depois, **diagnosticar, tratar e orientar** as dermatoses comuns, sem subestimar a história clínica.

A pele da criança

Funções: proteção, termorregulação, sensibilidade, excreção e função metabólica. A pele infantil é imatura, fina, frágil e sensível, com **maior relação superfície/peso**, o que significa mais perda de água e **mais absorção de produtos tópicos** (razão da cautela com corticoide e ureia). É estéril ao nascer e colonizada no fim da 1ª semana (estafilococo coagulase negativo, estreptococos, micrococos). A “maturidade” chega aos **2 a 3 anos**.

Alterações fisiológicas do recém-nascido (resolvem sem tratamento)

Alteração	Como é	Evolução
Vérnix caseoso	Substância graxenta (lubrificação, proteção antibacteriana e antioxidante); abundante no termo, quase ausente no prematuro	Some em horas. **SBP (2021): não dar banho nas primeiras 24 horas**
Descamação fisiológica	Escamas finas não aderentes, mais evidente no pós-termo	Some com ou sem tratamento

Alteração	Como é	Evolução
Hiperplasia sebácea	Pápulas amareladas no folículo, por andrógenos maternos	Semanas
Mílio	Pápulas brancas (cistos de queratina), em 50% dos RN	4 a 6 semanas
Pérolas de Epstein e nódulos de Bohn	Nódulos branco-nacarados no palato e gengiva (restos epiteliais)	Semanas a meses
Pele marmorata	Coloração arroxeada reticulada ao frio	Some com aquecimento
Acrocianose	Cianose de mãos e pés, normal nas primeiras 48 h	Melhora com aquecimento
Fenômeno de Arlequim	Metade do corpo vermelha e metade pálida em decúbito lateral, do 2º ao 5º dia; mais em prematuros (imaturidade hipotalâmica)	Dura 30 s a 20 min; face e genitais poupados

Dermatoses do período neonatal: as quatro benignas

	Eritema tóxico	Miliária	Melanose pustulosa transitória	Acne neonatal
Lesão	Pápulas ou pústulas esbranquiçadas com **halo eritematoso** (“picada de inseto”)	Vesículas: cristalina (pescoço e axila, subcórnea) ou rubra (“brotoeja”, inflamada, com prurido)	Vesículas e pústulas **sem eritema**, que deixam **máculas hiperpigmentadas**	“Espinhas” em face e costas
Quando	**3º ao 4º dia**, regride do 5º ao 14º	Calor e umidade	**Presente ao nascimento**	30% dos RN no 1º mês, até o 6º

	Eritema tóxico	Miliária	Melanose pustulosa transitória	Acne neonatal
Pista	**Poupa palmas e plantas**; raro em prematuros e abaixo de 2.500 g; estéril; assintomático	Obstrução do ducto sudoríparo	Pústulas assépticas somem em 24 a 48 h; manchas em 3 semanas a 3 meses	Hormônios maternos
Conduta	Nenhuma	Evitar calor, roupas leves de algodão; calamina ou amido se necessário; resolve em cerca de 2 semanas	Nenhuma	Nenhuma

Mancha mongólica: mácula azul-acinzentada congênita por melanócitos que pararam na derme durante a migração da crista neural; aumenta no 1º ano e a maioria desaparece na infância.

Lesões vasculares: benignas versus com potencial de complicação

	Mancha salmão	Mancha vinho do Porto	Hemangioma congênito
Natureza	Ectasia de capilares dérmicos	Malformação capilar congênita (gene GNAQ)	Tumor vascular vinhoso
Comportamento	Some à compressão, acentua ao choro. Pálpebra e glabela somem no 1º ano; occipital pode persistir até 6 anos ou a vida adulta	**Não involui**; cresce proporcional à criança	Maioria resolve até 5 anos: rapidamente involutivo (6 a 14 meses), parcialmente involutivo (12 meses) ou não involutivo

	Mancha salmão	Mancha vinho do Porto	Hemangioma congênito
Alerta	Benigna	**Em hemiface: síndrome de Sturge-Weber** (epilepsia, hemiplegia, deficiência intelectual, glaucoma): ressonância de encéfalo, neuropediatra e oftalmologista	Potencial de complicação
Tratamento	Nenhum	Laser	**Propranolol oral 2 a 3 mg/kg/dia de 8/8 h por 6 a 12 meses**, ou colírio de timolol tópico; cirurgia ou laser

Dermatite da área das fraldas

Irritativa primária (não alérgica): contato com fezes e urina mais oclusão e maceração. Eritema em **"W"** nas nádegas, genitais, coxas internas e abdome inferior, **poupando as dobras**.

Complicação por Candida albicans: eritema mais intenso, **lesões satélites** e **acometimento das dobras**. Também pode infectar por S. aureus ou estreptococo.

Diagnósticos diferenciais: dermatite seborreica, psoríase, eczema atópico, candidíase perianal, dermatite estreptocócica, impetigo bolhoso, escabiose, acrodermatite enteropática, histiocitose de células de Langerhans, granuloma glúteo infantil, sífilis congênita.

Etapa	Conduta
Prevenção	Troca frequente; limpeza com algodão e água (urina), água e óleo vegetal (fezes, remove as lipases) ou sabonete de pH adequado sem perfume; creme de barreira a cada troca (**óxido de zinco, dexpantenol**). **Evitar lenços umedecidos. Nistatina não é creme de barreira**
Casos moderados	Hidrocortisona 1% creme 2 vezes ao dia por até 3 a 4 dias, mais creme de barreira

Etapa	Conduta
Candidíase	Nistatina ou miconazol creme 2 vezes ao dia, ou cetoconazol 1 vez ao dia, **por 2 semanas**
Persistente	Acrescentar nistatina oral, 1 mL em cada canto da boca 4 vezes ao dia por 14 dias

Dermatite seborreica versus dermatite atópica

	Dermatite seborreica (“crosta láctea”)	Dermatite atópica
Início	**1º mês** (2ª a 10ª semana); até 70% dos bebês	**Após o 3º mês**
Evolução	Autolimitada; resolve do 6º ao 8º mês, até 1 ano	Crônica e recidivante
Lesão	Eritemato-descamativa com **escamas graxentas amareladas**	Fase aguda: placas eritematosas, vesículas, exsudação; subaguda: crostas; crônica: seca e **liquenificada**
Local	Couro cabeludo, centro da face, cílios, orelhas, retroauricular, dobras e fraldas	Lactente (3 meses a 2 anos): face **poupando o maciço central** e extensoras; infantil (2 a 12 anos): **dobras flexoras** (antecubital e poplítea); adolescente: dobras e face
Prurido	Incomum	**Sempre presente** (o principal sintoma)
Pele	Hidratação normal	**Seca (xerose)**
História familiar	Sem relação	Atopia (asma, rinite, urticária)

Sinais da dermatite atópica: sinal de Hertoghe (rarefação lateral das sobrancelhas) e dupla prega de Dennie-Morgan na pálpebra inferior. Mecanismo: defeito da barreira cutânea com citocinas IL-4, IL-5 e IL-13, IgE e eosinofilia nos casos graves.

Tratamento da seborreica: vaselina ou óleo mineral por 15 a 20 min para amolecer as escamas e remover com fricção suave; hidrocortisona 1% por 3 a 5 dias, em área limitada; cetoconazol 2% em xampu (3 minutos, 3 vezes por semana) ou creme; inibidores de

calcineurina como opção cara.

Tratamento da atópica, em degraus:

1. **Medidas gerais:** evitar o que piora a xerose (banho quente e longo, excesso de sabonete, bucha, tecido sintético ou lã, perfume).
2. **Hidratação** com hidratante de pH fisiológico, branco, sem perfume. **Não usar hidratante com ureia.**
3. **Corticoide tópico até melhorar o quadro agudo:** hidrocortisona 1% em face e dobras; média potência nas demais áreas (exemplos: mometasona, desonida, metilprednisolona aceponato). O mais potente da tabela é o clobetasol (grupo I).
4. **Inibidores de calcineurina** (poupam corticoide, não atrofiam; bons para face, genitais e dobras): pimecrolimo 1% creme a partir de 2 a 3 meses; tacrolimo 0,03% pomada a partir de 2 anos.
5. **Sistêmico:** anti-histamínico de 1ª geração à noite (hidroxizina, dexclorfeniramina) e de 2ª de dia (desloratadina, loratadina). **Evitar corticoide sistêmico (rebote).** Casos graves: ciclosporina ou metotrexato.

Micoses superficiais

Doença	Agente	Clínica	Tratamento
Tinea capitis	Microsporum, Trichophyton	Placas descamativas com **pelos fraturados (tonsurados)**; não deixa alopecia cicatricial	**Sempre sistêmico, 6 a 8 semanas**: griseofulvina 15 a 20 mg/kg/dia (máx. 750 mg), terbinafina, itraconazol ou fluconazol. Diagnóstico: exame micológico direto, cultura e lâmpada de Wood
Kérion	Mesmos	Reação inflamatória intensa (pápulas, pústulas) que **pode deixar alopecia cicatricial**	Sistêmico, como na tinea capitis; a duração depende do agente e do fármaco (Microsporum costuma exigir mais tempo que Trichophyton)

Doença	Agente	Clínica	Tratamento
Tinea corporis, cruris e pedis	Dermatófitos	Placas com **bordas descamativas e clareamento central**, crescimento centrífugo; pedis com maceração entre os dedos	**Tópico por 4 semanas**: miconazol, clotrimazol (2 vezes ao dia), cetoconazol, isoconazol (1 vez ao dia)
Pitiríase versicolor	Malassezia (residente da pele)	Máculas circulares bem delimitadas hipo ou hipercrômicas com descamação fina, em tronco e face; **sinal de Zileri** (estirar a pele descama)	Cetoconazol ou miconazol creme, ou xampu de cetoconazol (5 min, 3 vezes por semana, 8 semanas)
Candidíase oral	Candida	Pseudomembrana branca que, removida, deixa base eritematosa; pode haver queilite angular	**Nistatina suspensão 100.000 UI/mL, 1 mL em cada canto da boca de 6/6 h por 10 a 14 dias**. Em criança maior, pensar em imunodeficiência

Pegadinha: a **pitiríase alba não é fungo** (nem “verme”). É uma dermatose inflamatória que inibe a melanogênese: manchas hipocrômicas de bordas **mal definidas** em áreas expostas, piora com sol, banho quente e excesso de sabão. Trata-se como dermatite atópica. A pitiríase versicolor tem bordas **bem** delimitadas e é fúngica.

Estrófulo (prurigo estrófulo, urticária papular)

Reação de **hipersensibilidade a antígenos da saliva de insetos** (mosquitos, pulgas, carrapatos): pápulas eritematosas ou pequenas vesículas muito pruriginosas. **Começa entre 12 e 24 meses** (muito raro antes de 6 meses); a tolerância surge por volta dos 10 anos. Prevenção: controle ambiental, roupas, telas e repelentes. Tratamento do prurido: corticoide tópico de média a alta potência 1 vez ao dia por 5 dias (mometasona, metilprednisolona, betametasona) e anti-histamínico oral (1ª geração: dexclorfeniramina, hidroxizina; 2ª: desloratadina, fexofenadina).

Ectoparasitoses

	Pediculose	Escabiose
Agente	Pediculus humanus capitis (fêmea vive 1 mês, 7 a 10 ovos por dia, eclodem em 8 dias)	Sarcoptes scabiei (ácaro), geralmente transmitido de pais para filhos
Clínica	Prurido por reação à saliva	Pápulas escoriadas, **prurido que piora à noite**; na criança pode predominar em **palmas e plantas**
Tratamento	**O mais importante é a remoção mecânica das lêndeas com pente fino**: os medicamentos não matam os ovos. Permetrina 1% loção (10 min no cabelo úmido, repetir em 7 a 10 dias) ou deltametrina; ivermectina 0,2 mg/kg acima de 15 kg	**Permetrina 5% loção: 1ª escolha acima de 2 meses**, no corpo todo (em crianças incluindo face e couro cabeludo), à noite por 8 a 14 h, repetir em 7 e 14 dias. **Abaixo de 2 meses: enxofre 5 a 10%** por 3 noites. Ivermectina 0,2 mg/kg acima de 15 kg
Contatos e objetos	Piolho vivo 24 h após tratamento: uso incorreto, eclosão, reinfestação ou resistência; trocar o pediculicida. Lavar roupas e pentes; o que não for lavado fica 2 semanas sem uso	**Tratar todos os contatos íntimos ao mesmo tempo, com ou sem lesão.** Roupas não laváveis em saco plástico por 7 dias

Viroses de pele

- **Verrugas virais (HPV):** pápulas diminutas, planas ou hiperceratóticas; transmissão direta ou por objetos, facilitada por lesão da pele. Tratamento destrutivo (queratólise com ácido salicílico e láctico, crioterapia, curetagem, laser), antimitótico ou imunoestimulante.
- **Molusco contagioso (poxvírus):** pápulas de 3 a 6 mm, róseo-peroladas, **umbilicadas**, com pouco ou nenhum prurido; transmissão direta, autoinoculação ou fômites. Diagnóstico clínico. Tratamento destrutivo (curetagem, crioterapia, expressão).
- **Doença mão-pé-boca (enterovírus, Coxsackie A16, A6, A71 e outros):** surtos, abaixo de 5 anos, incubação de 4 a 7 dias, transmissão respiratória e pelas feridas. **Erosões orais** (língua, palato, amígdalas), febre baixa, vesículas que viram crosta em mãos, pés, nádegas e pernas. Tratamento de suporte (analgésico, antitérmico, prevenir desidratação). Complicação: **perda da unha**. Apenas 1% dos adultos e adolescentes infectados manifesta doença.

Piodermites

Doença	Camada	Agente	Clínica	Tratamento
Impetigo crostoso	Epiderme	1º S. aureus, 2º misto, 3º S. pyogenes	Vesícula sobre base eritematosa que forma **crosta melicérica**	**Tópico como 1ª linha em área limitada**: mupirocina ou ácido fusídico 3 vezes ao dia por 7 dias (retapamulina 2 vezes ao dia por 5 dias). Extenso: cefalexina ou oxacilina por no mínimo 7 dias
Impetigo bolhoso	Epiderme	**S. aureus (quase 100%)**	Vesículas que viram bolhas purulentas e rompem	Idem
Erisipela	Derme e linfáticos	Estreptococo beta-hemolítico do grupo A	**Placa bem delimitada**, eritematoedematosa, dolorosa, de progressão rápida, com febre alta, calafrios e adenopatia; na criança, **face**	Penicilina G cristalina ou ampicilina; se estafilococo, oxacilina ou cefazolina; amoxicilina com clavulanato; alérgico, clindamicina. **Não usar penicilina benzatina**
Celulite	Subcutâneo (hipoderme)	S. aureus, S. pyogenes; **H. influenzae abaixo de 2 anos**	**Placa mal delimitada**, infiltrada, dor, calor	7 a 10 dias: oxacilina ou cefalotina; cefalexina em casos leves ou sequencial; alérgico, macrolídeo ou clindamicina

Doença	Camada	Agente	Clínica	Tratamento
Furúnculo e abscesso	Folículo e glândula; coleção	S. aureus	Nódulo doloroso; coleção purulenta	**Drenagem** mais antibiótico antiestafilocócico
Fasciite necrotizante	Derme, hipoderme e fáscia		Comprometimento sistêmico	Emergência

Impetigo, pontos que caem: não usar penicilina V, amoxicilina simples, neomicina com bacitracina nem água oxigenada. Deixa de transmitir **24 h após antibiótico eficaz**. Complicações: celulite, abscesso e **glomerulonefrite pós-estreptocócica em 1 a 5% do impetigo crostoso; o antibiótico não reduz esse risco**.

Celulite periorbitária (pré-septal) versus orbitária (pós-septal): a pré-septal trata-se com antibiótico (oxacilina); a orbitária exige antibiótico (oxacilina mais ceftriaxona) e pode exigir cirurgia. **Na dúvida, tomografia.**

Adolescência: acne e fotoproteção

Acne: doença da unidade pilossebácea, multifatorial (mais sebo, hiperqueratinização, proliferação bacteriana, inflamação), com impacto psicológico; corticoides, fenitoína e lítio podem desencadear.

Grau	Lesões	Tratamento (conforme o grau)
Leve	Comedões abertos e fechados, poucas pápulas e pústulas	Retinoide tópico
Moderada	10 a 40 pápulas e pústulas, muitos comedões, tronco	Retinoide e antibiótico tópico; antibiótico oral
Grave	Mais de 40 pápulas e pústulas, nódulos em face, peito e costas	Antibiótico oral; anticoncepcional antiandrogênico
Muito grave	Nodulocística, dolorosa	Isotretinoína

Fotoproteção:

- **Abaixo de 6 meses:** não expor ao sol diretamente; só proteção mecânica (sombrinha, boné, roupa).
- **De 6 meses a 2 anos:** filtro **físico (inorgânico)**, com dióxido de titânio ou óxido de zinco. Protege imediatamente, cobre UVA e UVB, mas espalha mal (rótulos “baby”).

- **Acima de 2 anos:** filtro **químico (orgânico)**, que leva pelo menos 20 minutos para agir, protege em geral só UVB e é mais alergênico (rótulos “kids”).
- **Reaplicar** a cada 2 horas, após esporte intenso ou após mar e piscina.
- **Primeiro o protetor, depois o repelente.** FPS mede proteção UVB; PPD mede proteção UVA.

> **Como cai na prova.** (1) Eritema tóxico: 3º a 4º dia, poupa palmas e plantas, sem tratamento. Melanose pustulosa: já presente ao nascer, sem eritema, deixa mancha. (2) Mancha vinho do Porto em hemiface: Sturge-Weber. (3) Hemangioma: propranolol. (4) Dermatite de fralda poupa dobras; Candida atinge dobras e faz lesões satélites. (5) Nistatina não é creme de barreira; evitar lenço umedecido. (6) Seborreica: 1º mês, sem prurido, escama graxenta. Atópica: após 3 meses, prurido, xerose, poupa o maciço central no lactente. (7) Atópica: não usar ureia nem corticoide sistêmico. (8) Tinea capitis: sempre sistêmico. Corporis: tópico. (9) Pitiríase alba não é fungo. (10) Escabiose: permetrina 5% acima de 2 meses, enxofre abaixo, tratar todos os contatos. (11) Pediculose: pente fino é o mais importante. (12) Impetigo bolhoso é S. aureus; tópico em área limitada; antibiótico não previne GNDA. (13) Erisipela bem delimitada, celulite mal delimitada; erisipela não se trata com benzatina. (14) Filtro físico de 6 meses a 2 anos; químico acima de 2 anos; protetor antes do repelente.

Aula 15. Doenças exantemáticas

O diagnóstico diferencial dos exantemas se resolve com quatro perguntas: (1) qual a idade, (2) como é o pródromo, (3) qual a relação entre a febre e o exantema, (4) qual o sinal patognomônico. A tabela abaixo é o resumo mais importante desta aula; depois vêm os detalhes de cada doença.

Tabela-mestra

Doença	Agente	Idade	Febre e exantema	Sinal-chave	Tratamento
Sarampo	Morbillivirus	Maior risco de 6 a 12 meses	Exantema no 3º a 4º dia de febre alta; febre persiste junto	Tríade tosse, coriza, conjuntivite; manchas de Koplik	Vitamina A

Doença	Agente	Idade	Febre e exantema	Sinal-chave	Tratamento
Rubéola	Rubivirus	Crianças e adultos jovens	Febrícula; exantema róseo some em 3 dias	Linfonodos retroauriculares, occipitais e cervicais posteriores uma semana antes	Sintomático
Escarlatina	Estreptococo do grupo A com toxina eritrogênica	5 a 15 anos	Febre alta, amigdalite, exantema em 24 a 48 h	Pele em lixa, sinal de Pastia, Filatov, língua em morango	Penicilina ou amoxicilina
Exantema súbito (roséola)	Herpesvírus humano 6 (e 7)	6 meses a 3 anos (média 9 meses)	**Exantema surge quando a febre cai**	Febre alta sem foco por 3 a 5 dias	Sintomático
Eritema infeccioso	Parvovírus B19	Escolares	**Sem febre na fase exantemática**	Face esbofeteada; exantema rendilhado que volta com calor	Sintomático
Varicela	Vírus varicela-zoster	Crianças	Febre proporcional ao número de lesões	Polimorfismo regional, distribuição centrípeta	Sintomático; aciclovir em casos especiais
Mononucleose	Vírus Epstein-Barr	Adolescentes e escolares	Febre, faringite, adenopatia	Exantema após amoxicilina; esplenomegalia	Sintomático
Kawasaki	Vasculite, causa desconhecida	85% abaixo de 5 anos	Febre de 5 dias ou mais sem resposta a antibiótico	Conjuntivite sem secreção, lábios fissurados, edema de mãos e pés	Imunoglobulina e AAS
Meningococcemia	Neisseria meningitidis	Qualquer	Febre alta, toxemia contínua	Petéquias e púrpuras que progridem em horas	Ceftriaxona e suporte intensivo
SSJ e NET	Medicamento	Qualquer	Semanas após o fármaco	Bolhas, descolamento, mucosas	Suspender o fármaco; imunoglobulina

Sorologia geral: IgM costuma positivar por volta do 5º dia de doença; aumento de 4 vezes do IgG entre duas amostras confirma infecção recente. Exantemas por medicamento, EBV e enterovírus podem assumir qualquer padrão.

Sarampo

- **Transmissão:** aerossóis (máscara N95), de 4 dias antes a 4 dias após o exantema. Incubação de 8 a 12 dias.
- **Evolução:** pródromo com febre alta e a tríade tosse, coriza e conjuntivite; **manchas de Koplik** na mucosa jugal 1 a 2 dias antes do exantema; exantema morbiliforme no 3º a 4º dia, de progressão **craniocaudal**, que escurece (acastanhado) e descama em furáceo; some por volta do 9º dia.
- **Febre que persiste após o exantema sugere complicação** (otite, pneumonia). Maior risco de complicação abaixo de 5 anos e acima de 20 anos. Panencefalite esclerosante subaguda (PEES) surge 7 a 10 anos depois, com risco maior se o sarampo ocorreu antes dos 2 anos.
- **Tratamento:** vitamina A; ribavirina apenas em imunossuprimidos.
- **Vacina:** tríplice viral aos 12 meses e segunda dose aos 15 meses (tetraviral); duas doses até 29 anos, uma dose de 30 a 49 anos. Em surtos, "dose zero" de 6 a 12 meses, que não conta para o esquema.
- **Pós-exposição:** vacina de bloqueio em até 72 h; imunoglobulina em até 6 dias (protege cerca de 4 semanas).

Rubéola

- Transmissão de 5 a 7 dias antes até 5 a 7 dias após o exantema; incubação de 2 a 3 semanas.
- **Linfadenomegalia retroauricular, occipital e cervical posterior** aparece cerca de uma semana antes do exantema e persiste por semanas. Exantema róseo, começa na face, dissemina rápido e some em cerca de 3 dias sem descamar ("doença dos três dias"). Hemograma pode mostrar plasmocitose.
- **Sarampo versus rubéola:** o sarampo é lento, toxemiante e descama; a rubéola é rápida, leve e não descama.
- Complicações: encefalite, púrpura trombocitopênica, artrite, miocardite; a mais grave é a síndrome da rubéola congênita. Imunoglobulina só em gestantes.

Escarlatina

- Idade de 5 a 15 anos, incubação de 1 a 7 dias. Febre alta (39 a 40 °C), amigdalite purulenta e petéquias no palato.
- Exantema em "**pele em lixa**" nas primeiras 24 a 48 h, começando em pescoço, axilas e virilha; **sinal de Pastia** (acentuação em dobras); **sinal de Filatov** (palidez perioral).
- **Língua:** saburrosa (branca) nos dias 1 e 2, depois **em morango** quando a camada branca descama.

- Descamação lamelar a partir da 1ª semana, mais evidente entre a 2ª e a 3ª semana, em mãos e pés.
- Leucocitose e eosinofilia. Tratamento com penicilina ou amoxicilina, que **previne febre reumática, mas não a glomerulonefrite pós-estreptocócica**.

Exantema súbito (roséola infantil)

- Herpesvírus humano 6 (e 7). De 6 meses a 3 anos, média de 9 meses (queda dos anticorpos maternos). Incubação de 7 a 17 dias.
- Febre alta sem foco por 3 a 5 dias, com convulsão febril em 10 a 15%. **A febre desaparece subitamente e só então surge o exantema**, máculo-papular discreto, no tronco e pescoço, durando de horas a 3 dias, sem descamação.
- Leucocitose com neutrofilia nos dias 1 e 2 (confunde com bactéria), depois leucopenia com linfocitose. Ganciclovir só em imunossuprimidos.

Eritema infeccioso (quinta doença)

- Parvovírus B19, com tropismo por precursores eritroides da medula. Escolares (a aula cita 5 a 15 anos no caso e 2 a 12 anos nas características). Gotículas; transmite mais **antes** do exantema. Incubação de 5 a 10 dias; pródromo leve de 2 dias.
- **Três fases:** (1) face esbofeteada com palidez perioral; (2) após 24 a 48 h, exantema rendilhado em tronco e superfícies extensoras, por 1 a 2 semanas; (3) reaparecimento com exercício, calor, sol, trauma ou estresse, por semanas, **sem ser nova infecção**.
- **Sem febre na fase exantemática**; criança em bom estado.
- **Complicação-chave:** crise aplástica transitória em pacientes com anemia falciforme ou outras anemias hemolíticas (a produção para e as hemácias, que já vivem pouco, não são repostas), podendo exigir transfusão. Em imunodeficientes, infecção crônica, tratada com imunoglobulina.
- Diagnóstico clínico; IgM anti-parvovírus confirma; PCR em imunodeprimidos.

Varicela

- Vírus varicela-zoster (herpesvírus, DNA). Aerossóis e contato com lesões (N95); transmite de 2 dias antes do exantema **até todas as lesões virarem crosta**. Incubação de 14 a 16 dias.
- Lesões evoluem em 8 a 48 h: mácula, pápula, vesícula (“gota de orvalho sobre pétala de rosa”), pústula, crosta. Surgem em **surtos** (3 a 5 por dia), por isso coexistem lesões em todos os estágios: **polimorfismo regional**. Distribuição **centrípeta** (tronco, face, couro cabeludo). Acomete mucosas.
- A febre acompanha o surgimento de novas lesões e cede quando elas param.

- Formas graves em adolescentes e adultos (pneumonite varicelosa).
- **Tratamento:** sintomático (antitérmico, anti-histamínico, cuidado com a pele). Aciclovir para imunocomprometidos, casos graves e risco de complicação.
- **Profilaxia:** vacina a partir de 12 meses. Pós-exposição: vacina em até 5 dias; imunoglobulina específica em até 10 dias para alto risco.

Mononucleose infecciosa

- Vírus Epstein-Barr; saliva e secreções orais; eliminação viral por meses. **Incubação longa, de 30 a 50 dias.**
- **Tríade: febre, faringite e linfadenopatia** (cervical posterior, múltipla). Fadiga intensa e prolongada. Amigdalite membranosa que imita a estreptocócica. Hepatoesplenomegalia, com risco de ruptura esplênica (evitar esporte de contato).
- **Exantema:** espontâneo em 3 a 8%; após amoxicilina ou ampicilina, em 80 a 100%. **Não é alergia verdadeira à penicilina.**
- Laboratório: linfocitose com **linfócitos atípicos acima de 20%**; anti-VCA IgM confirma infecção aguda; PCR para EBV.

Doença de Kawasaki

- Vasculite aguda de artérias de pequeno e médio calibre; 85% abaixo de 5 anos; principal causa de cardiopatia adquirida na infância. A grande preocupação é o **aneurisma coronariano**.
- **Critérios:** febre por 5 dias ou mais com 4 dos 5 critérios abaixo, ou 3 critérios com aneurisma documentado.

Mnemônico “CREAM” [mnemônico clássico, complemento]:

Letra	Critério	Frequência
C	Conjuntivite bilateral **não exsudativa**	88%
R	Rash (exantema) polimorfo, sem vesículas	Comum
E	Extremidades: edema e eritema palmoplantar; descamação periungueal na fase subaguda (2ª semana)	88 a 94%
A	Adenopatia cervical, geralmente unilateral, acima de 1,5 cm	50 a 75%
M	Mucosa oral: lábios vermelhos e fissurados, língua em morango	90%

- **Cronologia vascular:** inflamação da parede do 6º ao 9º dia; aneurismas começam por volta do 10º dia, com pico na 3ª semana, raros após 4 semanas. São silenciosos, por isso ecocardiograma seriado.
- **Laboratório:** anemia normocítica, leucocitose acima de 20.000, VHS e PCR altos, **plaquetose na 3ª semana**, hipoalbuminemia, transaminases altas, **piúria estéril**, autoanticorpos negativos.
- **Tratamento:** imunoglobulina endovenosa 2 g/kg dose única, idealmente até o 10º dia de febre (reduz aneurismas de 25% para menos de 4%), com AAS em dose moderada (30 a 50 mg/kg/dia) ou alta (50 a 80 mg/kg/dia); após 48 h afebril, AAS 3 a 5 mg/kg/dia por 6 a 8 semanas (ou mais, se houver alteração coronariana).

Kawasaki versus escarlatina: ambos têm língua em morango, mas Kawasaki não responde a antibiótico, tem edema de extremidades, exantema polimorfo e descamação perineal precoce.

Farmacodermias: SSJ e NET

- Medicamentos mais envolvidos: analgésicos e AINE (38%), antimicrobianos (36%), anticonvulsivantes (24%), corticoides (14%). Destaques: **fenobarbital, carbamazepina, fenitoína**, sulfonamidas, penicilinas, cefalosporinas, alopurinol.
- Latência de semanas após o início do fármaco (no caso da aula, cerca de 1 mês após fenobarbital).
- **Espectro pela área de descolamento:** Síndrome de Stevens-Johnson (SSJ) abaixo de 10% da superfície corporal com 2 ou mais mucosas; sobreposição de 10 a 30%; Necrólise Epidérmica Tóxica (NET) acima de 30%. Eritema multiforme é mais benigno, com lesões em alvo e pouco ou nenhum acometimento mucoso.
- **Mecanismo:** o fármaco ativa o sistema imune, que produz ligante de Fas (FasL); ele se liga ao receptor do queratinócito e dispara apoptose em massa, descolando a epiderme.
- **Conduta:** suspender imediatamente o fármaco; tratar como grande queimado (internação, hidroeletrolítico, cuidado de pele e mucosas, avaliação oftalmológica). Imunoglobulina adjuvante (2 g/kg dose única, ou 1 g/kg/dia por 2 dias, ou 500 mg/kg/dia por 4 dias), que bloqueia a ligação FasL-receptor.

Meningococcemia

- Neisseria meningitidis; gotículas (máscara cirúrgica); incubação de 1 a 10 dias, média de 4.
- Início abrupto, febre acima de 39,5 °C, **prostração mesmo sem febre** (a virose melhora quando a febre cede; a meningococcemia não).

- Petéquias de distribuição centrífuga (membros inferiores, conjuntivas, mucosas) que evoluem em horas para púrpuras, equimoses e necrose. Em 12 a 24 h pode haver choque, CIVD e falência de múltiplos órgãos.
- **Mecanismo:** coloniza a nasofaringe; cepas com IgA protease atravessam a mucosa; a endotoxina (LPS) causa lesão endotelial, vasodilatação, CIVD e depressão miocárdica. Hemorragia adrenal maciça = síndrome de Waterhouse-Friderichsen.
- **Regra de ouro:** criança febril com petéquias é meningococcemia até prova em contrário. Internar, antibiótico endovenoso (cefalosporina de 3ª geração) imediatamente, sem esperar exames, e suporte intensivo.

> **Como cai na prova.** (1) Exantema que aparece quando a febre some: exantema súbito. (2) Exantema com febre persistente após seu surgimento no sarampo: complicação. (3) Amigdalite, amoxicilina e exantema: mononucleose, não alergia. (4) Lesões em vários estágios: varicela. (5) Anemia falciforme com piora súbita da anemia e reticulócitos baixos: parvovírus B19. (6) Febre de 6 dias sem resposta a antibiótico, lábios fissurados e edema de mãos: Kawasaki, imunoglobulina até o 10º dia. (7) Pele em lixa com Pastia: escarlatina. (8) Linfonodo retroauricular antes do exantema: rubéola. (9) Bolhas e mucosas 1 mês após anticonvulsivante: SSJ, suspender o fármaco. (10) Petéquias com prostração mesmo afebril: meningococcemia.

Urgências e doenças de pele

A professora deu uma aula própria, **“Atendimento de urgência e das diarreias em pediatria”**, que é a fonte mais provável da questão isolada de urgência e das 2 de diarreia. O método dela vem primeiro, abaixo. Depois vêm as situações graves espalhadas pelas outras aulas, que alimentam a questão “de urgência dentro das doenças”.

O método da aula de Urgência: “não trate a diarreia, trate a criança”

Sequência mental para toda criança no pronto atendimento:

1. **Impressão inicial** (sem tocar): estável ou instável?
2. Se instável: **ABCDE**, avaliando, identificando, intervindo e reavaliando.
3. Avaliar a **hidratação** pelo conjunto de sinais.
4. Escolher o **Plano A, B ou C**.
5. Tratar.
6. **Reavaliar**, porque a reavaliação pode mudar o plano.

Triângulo da impressão inicial (“esta criança parece gravemente doente?”)

Aparência e consciência	Respiração	Cor e perfusão
Interação, tônus, responsividade	Esforço, movimentos, sons	Palidez, cianose, moteamento

Avaliação primária ABCDE: A, via aérea; B, respiração; C, circulação; D, neurológico (inclui **glicemia**); E, exposição (exantema, sangramento, trauma). **Primeiro as ameaças à vida; depois a história detalhada.**

C: reconhecer hipoperfusão antes da hipotensão

- **Taquicardia é sinal precoce.**
- Perfusão periférica: tempo de enchimento capilar, temperatura e cor das extremidades, pulsos.
- **Pressão arterial pode estar normal no choque compensado. Hipotensão em pediatria é achado tardio:** não espere a pressão cair para reconhecer choque.

Avaliação secundária (SAMPLE): S, sinais e sintomas; A, alergias; M, medicamentos; P, passado médico; L, última ingestão; E, eventos relacionados.

Fenótipo da diarreia, para organizar o raciocínio: osmótica (fezes líquidas e volumosas); secretora (grande perda de água e eletrólitos); inflamatória (sangue, muco, febre, dor); motilidade. **O mecanismo organiza o raciocínio, mas não substitui a avaliação da gravidade.** No pronto atendimento, a complicação que muda a conduta é a desidratação.

O caso Miguel, passo a passo (modelo provável de questão)

Momento	Dados	Decisão
Chegada	18 meses, 10 kg; 8 evacuações líquidas, 4 vômitos, febre de 38,2 °C há 30 h; irmão com quadro igual; sem sangue ou muco; acordado, irritado, sem esforço respiratório, corado	Impressão inicial sem necessidade de intervenção imediata. Hipótese: gastroenterite viral, **mecanismo osmótico**. O que muda a conduta agora é o **estado de hidratação**, não coprocultura ou PCR
Exame	Irritado, olhos fundos, sem lágrimas, mucosa seca, **bebe avidamente**, TEC 2 s, FC 148, PA 88 × 52, quase sem diurese	**Com desidratação: Plano B.** Nenhum sinal isolado decide; vale o conjunto
Prescrição	Plano B	SRO 50 a 100 mL/kg em 4 a 6 h: **500 a 1.000 mL**, supervisionado no serviço

Momento	Dados	Decisão
Vômito após a SRO	Um episódio	**Não é falha da TRO:** oferecer volumes pequenos e frequentes, reofertar e reavaliar
Piora	Perdas volumosas, vômitos repetidos; sonolento, FC 168, FR 42, **PA 76 × 40**, TEC 4 s, extremidades frias, pulsos finos	O problema mudou para **criança gravemente enferma em choque hipovolêmico**. ABCDE: a ameaça está no **C** (glicemia de 86 mg/dL normal). **Plano C**
Pegadinha	“Se a PA fosse 90 × 55, excluiria choque?”	**Não:** no choque compensado a PA pode estar preservada
Plano C	Acesso, reidratação venosa, reavaliação, transição para via oral	Pelo cartaz, a partir de 1 ano: 30 mL/kg em 30 min (300 mL) e 70 mL/kg em 2 h 30 min (700 mL). **O que define a próxima conduta é a resposta clínica**
60 minutos depois	Alerta, FC 118, TEC menor que 2 s, extremidades quentes, pulsos melhores, aceita SRO, diurese presente	Esses são os **sinais de melhora da perfusão**. Segue a avaliação secundária (SAMPLE)

Caso-desafio (Lara, 4 anos, 16 kg): febre alta há 24 h, 6 evacuações com **sangue e muco**, dor abdominal, prostrada mas responsiva, olhos fundos, mucosa seca, TEC 3 s, bebe com avidez. Fenótipo **inflamatório (disentérico)**; hidratação classificada pelo conjunto; plano conforme a classificação mais investigação e terapia conforme o contexto (disenteria com comprometimento do estado geral tem indicação de antibiótico pelo cartaz).

Rapid fire da aula: ativa, olhos normais, bebe normal: **Plano A**. Irritada, olhos fundos, sedenta, boca seca: **Plano B**. Sonolento, TEC 5 s, pulso fino: **ABCDE e Plano C**. Febre, cólica, sangue e muco: **diarreia inflamatória**.

> **Como cai na prova (urgência).** (1) Ordem: impressão inicial, ABCDE, hidratação, plano, reavaliação. (2) Taquicardia é precoce; hipotensão é tardia; PA normal não exclui choque. (3) Classificação pelo conjunto, nunca por sinal isolado. (4) Vômito isolado não é falha da SRO. (5) Melhora da perfusão: FC caindo, TEC abaixo de 2 s, extremidades quentes, pulsos cheios, diurese. (6) SAMPLE vem depois de estabilizar. (7) Glicemia faz parte do D.

Urgências: reconhecer e agir

Situação	Como reconhecer	Primeira conduta	Aula
Meningococcemia	Febre alta súbita, **prostração mesmo sem febre**, petéquias que viram púrpuras em horas, extremidades frias, pulsos finos, enchimento lento, agitação alternando com sonolência	Internar, **cefalosporina de 3ª geração EV imediata sem esperar exames**, volume e drogas vasoativas, isolamento com máscara cirúrgica, quimioprofilaxia dos contatos	7 e 15
Meningite bacteriana	Febre, vômitos, rigidez de nuca, fontanela abaulada, convulsão	Hemocultura, punção lombar (tomografia antes se déficit focal; não puncionar se instabilidade, plaquetas abaixo de 50.000 ou infecção local), **dexametasona antes ou junto** do antibiótico empírico por idade	7
Encefalite herpética	Febre, convulsão focal, alteração de comportamento, lobo temporal	**Aciclovir EV** sem esperar confirmação	7
Desidratação grave	2 ou mais sinais com 1 asterisco: letárgico, não consegue beber, pulso fraco ou ausente	**Plano C**: 30 mL/kg e depois 70 mL/kg de SF ou Ringer (1 h + 5 h abaixo de 1 ano; 30 min + 2 h 30 min a partir de 1 ano)	8
Crise asmática grave	Fala só palavras, agitação ou sonolência, saturação abaixo de 90%, tórax silencioso	Salbutamol nebulizado, ipratrópio, corticoide sistêmico, O2; sem resposta, **sulfato de magnésio 25 a 75 mg/kg (máx. 2 g)**	5
Bronquiolite grave	Apneia, toxemia, FR acima de 70, saturação abaixo de 92%, desidratação	Internar, O2, aspiração, hidratação, cânula de alto fluxo; notificar como SRAG	6

Situação	Como reconhecer	Primeira conduta	Aula
Coqueluche abaixo de 6 meses	Apneia, cianose, bradicardia após tosse, sem guincho	Internar, azitromicina, precaução de gotículas, profilaxia dos contatos	6
Pneumonia com sinal de perigo	Abaixo de 2 meses: FR 60 ou mais, tiragem, febre ou hipotermia; 2 meses a 5 anos: tiragem, estridor, não bebe, convulsão	Internar; ampicilina mais gentamicina abaixo de 2 meses; ampicilina EV acima	4
Neutropenia febril	Febre com neutrófilos abaixo de 500	**Cefepime** imediato	1
Abscesso periamigdaliano	Voz “de batata quente”	Drenagem e amoxicilina com clavulanato ou clindamicina	3
Crise aplástica transitória	Paciente falciforme com queda brusca da hemoglobina e reticulócitos baixos (parvovírus B19)	Transfusão de hemácias	15
SSJ e NET	Bolhas, descolamento epidérmico e mucosas semanas após fármaco	**Suspender o fármaco**, tratar como grande queimado, imunoglobulina	15
Kawasaki	Febre de 5 dias ou mais com 4 critérios	Imunoglobulina 2 g/kg até o 10º dia e AAS; ecocardiograma	15
Mononucleose com esplenomegalia	Dor abdominal súbita após trauma ou esporte	Risco de ruptura esplênica; afastar de esportes de contato	15

Regra que vale para quase todas: na suspeita de infecção bacteriana grave (meningococcemia, meningite, neutropenia febril), **o antibiótico não espera o exame**.

Doenças de pele: lesões elementares (Aula 15)

Identificar a **lesão primária** é o primeiro passo; depois classifica-se o exantema em um grupo.

Lesões primárias	Definição
Mácula	Plana, sem relevo, só alteração de cor
Pápula	Sólida, elevada, circunscrita, até 1 cm
Nódulo	Sólida, mais profunda e maior que a pápula (derme profunda ou subcutâneo)
Tumor	Sólida de grandes dimensões
Urtica	Elevada, edematosa, eritematosa e **transitória**
Vesícula	Elevada com líquido claro
Bolha	Como a vesícula, porém maior
Pústula	Elevada com pus
Cisto	Cavidade revestida por epitélio com conteúdo líquido ou pastoso
Púrpura	Sangue extravasado que **não some à digitopressão**: petéquias (puntiformes), equimoses (maiores), sufusões (grandes placas)

Lesões secundárias	Definição
Escama	Descamação da epiderme superficial
Crosta	Ressecamento de sangue, secreção ou exsudato
Fissura	Fenda linear
Erosão	Perda **superficial** da epiderme
Úlcera	Perda que **ultrapassa a epiderme** e atinge derme ou planos profundos
Necrose	Morte tecidual
Cicatriz	Reparo com tecido fibroso
Liquenificação	Espessamento com sulcos acentuados por coçadura crônica
Hiperceratose	Aumento da camada córnea
Atrofia	Redução da espessura da pele

Enantema é o exantema nas mucosas (exemplo: manchas de Koplik). **Exantema** é mancha de fundo vascular; causas infecciosas, alérgicas, tóxicas e físicas.

Grupos de exantema: (1) **petequial ou purpúrico** (não some à digitopressão; pense em meningococcemia); (2) **pápulo-vesicular**, dividido em febril (varicela) e afebril; (3) **máculo-papular** (o mais comum: sarampo, rubéola, exantema súbito, escarlatina). Medicamentos, mononucleose e enterovírus podem produzir qualquer padrão.

Farmacodermias: o espectro

Quadro	Pele	Mucosas	Gravidade
Exantema medicamentoso simples	Eritema difuso	Não	Leve
Eritema multiforme	**Lesões em alvo**	Ausente ou discreta	Mais benigno
Síndrome de Stevens-Johnson	Descolamento **abaixo de 10%** da superfície	**2 ou mais**	Grave
Sobreposição SSJ/NET	**10 a 30%**	Sim	Grave
Necrólise epidérmica tóxica	**Acima de 30%**	Sim	Gravíssima; sepse e distúrbio hidroeletrolítico

Causas: AINE e analgésicos (38%), antimicrobianos (36%), anticonvulsivantes (24%), corticoides (14%); destaques fenobarbital, carbamazepina, fenitoína, sulfonamidas, alopurinol. Mecanismo: ligante de Fas induz apoptose maciça dos queratinócitos. Conduta: suspender o fármaco, internar, cuidar como queimado, avaliação oftalmológica, imunoglobulina (2 g/kg dose única, ou 1 g/kg/dia por 2 dias, ou 500 mg/kg/dia por 4 dias).

> **Como cai na prova.** (1) Erosão é superficial; úlcera atinge a derme. (2) Urtica é transitória. (3) Púrpura não desaparece à digitopressão. (4) Vesícula versus bolha é só tamanho. (5) SSJ abaixo de 10%, NET acima de 30%. (6) Lesão em alvo sem mucosa: eritema multiforme. (7) Febre com petéquias: antibiótico antes de qualquer exame.

Mapa de medicamentos: quando usar qual

Esta é a tabela de revisão da véspera. Leia a coluna “Situação”, cubra o resto e tente responder antes de olhar.

Antibióticos por situação

Situação	1ª escolha	Alternativa ou falha	Duração
Amigdalite estreptocócica	Penicilina benzatina IM (600.000 UI abaixo de 27 kg; 1.200.000 acima) ou amoxicilina	Falha: amoxicilina com clavulanato. Alergia leve: cefalexina. Grave: clindamicina ou azitromicina	10 dias (azitromicina 5)
Abscesso periamigdaliano	Drenagem mais amoxicilina com clavulanato	Clindamicina	
Otite média aguda	Amoxicilina (dose alta se creche ou antibiótico recente)	Amoxicilina com clavulanato, cefuroxima; 3ª linha ceftriaxona IM 1 a 3 dias	5 a 7 dias acima de 2 anos; 7 a 10 abaixo
Sinusite bacteriana	Amoxicilina	Amoxicilina com clavulanato em dose alta se risco de resistência	10 a 14 dias
PAC típica ambulatorial	Amoxicilina		5 a 7 dias
PAC atípica ou pneumonia afebril do lactente	Azitromicina	Claritromicina	5 dias
PAC internada a partir de 2 meses	Ampicilina ou penicilina cristalina EV	Oxacilina se S. aureus; ceftriaxona mais oxacilina se derrame complicado	
Infecção neonatal precoce (pneumonia ou meningite)	Ampicilina mais gentamicina	Ampicilina mais cefotaxima na meningite	

Situação	1ª escolha	Alternativa ou falha	Duração
Pneumonia neonatal tardia	Oxacilina mais gentamicina		
Meningite acima de 1 mês	Ceftriaxona ou cefotaxima	Mais vancomicina se pneumococo resistente	Meningo 5 a 7; Hib 7 a 10; pneumo 10 a 14
Meningococcemia	Cefalosporina de 3ª geração imediatamente		
Coqueluche (tratamento e profilaxia)	Azitromicina		5 dias
Escarlatina	Penicilina ou amoxicilina		10 dias
Neutropenia febril	Cefepime		
Diarreia com indicação de antibiótico	Azitromicina até 30 kg; ciprofloxacino acima de 30 kg (cartaz do Ministério da Saúde)	Ceftriaxona se grave	
Quimioprofilaxia de meningococo	Rifampicina 12/12 h por 2 dias	Ceftriaxona ou ciprofloxacino em dose única	
Quimioprofilaxia de Hib	Rifampicina 1 vez ao dia por 4 dias		

Antibióticos proibidos ou ruins em certas situações

- **Cefalexina:** não em OMA, sinusite ou pneumonia.
- **Ceftriaxona:** não abaixo de 28 dias de vida.
- **Cefalosporinas:** não cobrem Listeria (por isso ampicilina no recém-nascido).
- **Macrolídeos:** não como 1ª linha em sinusite ou OMA.
- **Amoxicilina na mononucleose:** provoca exantema em 80 a 100%.

Não antibióticos

Doença	Medicamento e dose	Observação
Anemia ferropriva	Ferro 3 a 6 mg/kg/dia por 3 a 6 meses	Profilaxia 1 mg/kg/dia
PTI	Observação; corticoide ou imunoglobulina se sangramento	
Crise asmática	Salbutamol; ipratrópio na moderada a grave; sulfato de magnésio 25 a 75 mg/kg (máx. 2 g) na grave	Ipratrópio sem benefício após internação
Asma, manutenção	Corticoide inalatório	Montelucaste é o único antileucotrieno abaixo de 12 anos
Bronquiolite	Nenhum fármaco de rotina; O2 se saturação abaixo de 92%	Palivizumabe e nirsevimabe são prevenção
Meningite bacteriana	Dexametasona 0,15 mg/kg 6/6 h por 2 a 4 dias	Antes ou junto do antibiótico
Encefalite herpética	Aciclovir EV	Sem esperar confirmação
Diarreia aguda	SRO, zinco 10 ou 20 mg por 10 dias, ondansetrona	Manter alimentação
TEA	Melatonina (sono); risperidona ou aripiprazol (irritabilidade)	Não tratam o núcleo do autismo
TDAH	Metilfenidato ou lisdexanfetamina (1ª); atomoxetina (2ª)	Com terapia cognitivo-comportamental
Dismenorreia	Ácido mefenâmico ou ibuprofeno (1ª); anticoncepcional oral (2ª)	
Ginecomastia	Tamoxifeno	Cirurgia se critérios
Puberdade precoce central	Análogo de GnRH	Suspender com IO 12,5 (meninas) e 13,5 (meninos)
Calazar	Anfotericina B lipossomal	
Sarampo	Vitamina A	Ribavirina só em imunossuprimido

Doença	Medicamento e dose	Observação
Varicela	Sintomático; aciclovir em imunocomprometido ou grave	
Kawasaki	Imunoglobulina 2 g/kg mais AAS	AAS 3 a 5 mg/kg/dia após 48 h afebril
SSJ e NET	Suspender o fármaco; imunoglobulina	
Coqueluche com convulsão	Fenobarbital	

Simulado 2: formato provável da prova

Segue a distribuição informada: adolescência e puberdade (1 a 6), hepatoesplenomegalia fácil, média e difícil (7 a 9), diarreia (10 e 11), IVAS isolada e com otite (12 e 13), meningite (14 e 15), pele (16 e 17), exantemáticas, uma com esplenomegalia (18 e 19), urgência isolada (20), urgência dentro de doença (21), bronquiolite e coqueluche (22 e 23), asma fácil (24), pneumonia (25) e hemograma misturado (26). As questões 27 a 30 são extras dos temas de maior peso. Faça em 60 minutos. Nas questões de afirmativas: A) 1; B) 2; C) 3; D) 4.

1. Sobre a adolescência, quantas afirmativas estão corretas?

I. Segundo a OMS, a adolescência vai dos 10 aos 19 anos; segundo o ECA, dos 12 aos 18 anos.

II. Nos dois primeiros anos após a menarca, cerca de 50% dos ciclos são anovulatórios.

III. Ausência de menstruação por 60 dias em adolescente com menarca há 1 ano deve, obrigatoriamente, ser investigada.

IV. O sigilo médico é garantido ao adolescente que tenha capacidade de compreender, refletir e problematizar sua condição de saúde.

2. Adolescente de 16 anos, menarca aos 13, relata cólicas menstruais intensas há 1 ano, que a fazem faltar à escola. Exame físico normal. Assinale a correta:

- A) Trata-se de dismenorreia secundária; o anticoncepcional oral combinado é a primeira linha.
- B) A dismenorreia primária é típica dos primeiros ciclos anovulatórios.
- C) O injetável trimestral é a primeira escolha por conter estrógeno e progesterona.
- D) O mecanismo é o excesso de prostaglandinas endometriais, e o AINE (por exemplo, ácido mefenâmico 500 mg, 3 a 4 vezes ao dia) é a primeira linha, com resposta em cerca de 80%.

3. Menino de 14 anos, Tanner G3, com nódulo firme, móvel e subareolar bilateral de 2 cm, levemente doloroso. Não usa medicações; restante do exame normal. A conduta é:

- A) Observação e acompanhamento, pois a ginecomastia puberal fisiológica costuma regredir espontaneamente.
- B) Mastectomia redutora imediata.
- C) Tamoxifeno para todos os casos, para evitar progressão.
- D) Tomografia de abdome e biópsia mamária.

4. Sobre saúde mental e comportamento na adolescência, quantas afirmativas estão corretas?

I. O gaming disorder exige padrão geralmente por pelo menos 12 meses e a presença de todas as suas características diagnósticas.

II. No uso problemático de mídias interativas (PIMU), o objetivo terapêutico é a abstinência completa das telas.

III. A automutilação tem pico entre 13 e 15 anos e, embora sem intenção suicida, aumenta o risco de suicídio.

IV. Pela Resolução CFM 2.427/2025, a hormonização cruzada é permitida a partir dos 16 anos.

5. Menina de 6 anos e 8 meses com telarca (M3) e pubarca (P2) há 4 meses, velocidade de crescimento de 9 cm/ano, idade óssea de 9 anos, relação LH/FSH acima de 1 e LH puberal após estímulo com GnRH. Assinale a correta:

- A) Trata-se de puberdade precoce periférica; o análogo de GnRH não está indicado.
- B) Trata-se de telarca precoce isolada; basta observar por 6 meses.
- C) Um estradiol sérico normal excluiria o diagnóstico.
- D) Trata-se de puberdade precoce central; o tratamento é com agonista de GnRH, com seguimento a cada 3 meses, podendo haver sangramento vaginal após a primeira dose.

6. Sobre a puberdade precoce, quantas afirmativas estão corretas?

I. Nos meninos com puberdade precoce central, cerca de 2/3 dos casos estão associados a anomalias neurológicas.

II. A ressonância de crânio está indicada em todas as crianças abaixo de 6 anos com puberdade precoce central.

III. No estágio G2, o volume testicular atinge cerca de 4 mL, sem aumento do pênis.

IV. A puberdade precoce periférica segue sequência harmônica, semelhante à fisiológica.

7. (Hepatoesplenomegalia, fácil) Sobre o exame do fígado e do baço na criança, assinale a correta:

- A) Acima de 10 anos, o fígado normalmente não é palpável abaixo do rebordo costal direito.
- B) Fígado palpável a 3 cm do rebordo em lactente de 6 meses é sempre patológico.
- C) Um baço claramente palpável tem no máximo 20% de aumento.
- D) A palpação deve preceder a ausculta abdominal.

8. (Hepatoesplenomegalia, média) Menina de 5 anos, de família de origem judaica, com dores ósseas recorrentes há 2 anos, esplenomegalia volumosa, anemia, plaquetopenia e leucócitos normais. Sem febre, sem icterícia e sem linfonodos. O diagnóstico mais provável é:

- A) Leucemia linfoide aguda.
- B) Esferocitose hereditária.
- C) Doença de Gaucher, por deficiência de glicocerebrosidase, com células de Gaucher no mielograma.
- D) Leishmaniose visceral.

9. (Hepatoesplenomegalia, difícil) Quantas afirmativas estão corretas?

I. Pancitopenia com leucopenia importante, hipergamaglobulinemia e hipoalbuminemia, em criança que vive perto de cães, sugere calazar, confirmado por amastigotas no aspirado de medula.

II. Leucócitos totais normais afastam leucemia aguda.

III. No recém-nascido com suspeita de infecção congênita, sorologias negativas não excluem completamente o diagnóstico.

IV. Calcificações periventriculares sugerem toxoplasmose congênita, e calcificações difusas sugerem citomegalovirose.

10. Criança de 3 anos, 14 kg, com diarreia há 2 dias. Está irritada, com olhos fundos, sedenta e bebendo avidamente, sem lágrimas; prega abdominal desaparece lentamente; pulso cheio. A conduta é:

- A) Plano A, no domicílio.
- B) Plano C, com 30 mL/kg de soro fisiológico em 30 minutos.
- C) Plano C, com 20 mL/kg repetidos até hidratar.
- D) Plano B: soro de reidratação oral 50 a 100 mL/kg em 4 a 6 horas no estabelecimento de saúde, reavaliando.

11. Lactente de 8 meses, 8 kg, letárgico, incapaz de beber, com pulso fraco e prega que desaparece em mais de 2 segundos. A fase de expansão correta é:

- A) 240 mL de soro fisiológico ou Ringer lactato em 1 hora, seguidos de 560 mL em 5 horas.
- B) 240 mL em 30 minutos, seguidos de 560 mL em 2 horas e 30 minutos.
- C) 160 mL em 20 minutos, repetidos conforme a resposta.
- D) Soro de reidratação oral 800 mL em 4 horas.

12. Escolar de 10 anos, 30 kg, com febre de 39 °C, exsudato amigdaliano, linfonodo cervical anterior doloroso e sem tosse. O teste rápido para estreptococo foi negativo. Assinale a correta:

- A) O teste rápido negativo exclui estreptococo do grupo A.
- B) A cefalexina é a primeira escolha.
- C) Deve-se colher cultura, pois o teste rápido tem alta especificidade e baixa sensibilidade; se positiva, penicilina benzatina 1.200.000 UI.
- D) Azitromicina por 3 dias é a primeira linha.

13. Criança de 18 meses que frequenta creche, com febre de 39,5 °C, otalgia intensa e abaulamento bilateral das membranas timpânicas. Usou amoxicilina há 3 semanas. A conduta é:

- A) Observação por 48 a 72 horas.
- B) Cefalexina por 10 dias.
- C) Amoxicilina em dose padrão por 5 dias.
- D) Amoxicilina em dose alta por 7 a 10 dias.

14. Criança de 5 anos com febre, cefaleia e rigidez de nuca. Líquor: 1.800 células (90% neutrófilos), glicose 18 mg/dL, proteína 220 mg/dL; Gram com diplococos gram-negativos. Assinale a correta:

- A) Ceftriaxona com dexametasona; tratar por 5 a 7 dias; quimioprofilaxia dos contatos íntimos com rifampicina.
- B) Aciclovir endovenoso.
- C) Ampicilina mais gentamicina por 21 dias.
- D) Vancomicina isolada, sem necessidade de profilaxia dos contatos.

15. Sobre meningites, quantas afirmativas estão corretas?

I. Na punção traumática, desconta-se 1 leucócito para cada 500 hemácias.

II. Plaquetas abaixo de 50.000/mm³ contraindicam a punção lombar.

III. A dexametasona tem benefício principalmente nas meningites por H. influenzae e pneumococo, protegendo a audição.

IV. A Listeria é sensível às cefalosporinas de terceira geração.

16. (Pele) Recém-nascido a termo de 3 dias, em bom estado, com pápulas esbranquiçadas envoltas por halo eritematoso no tronco e membros, poupando palmas e plantas. Assintomático. O diagnóstico e a conduta são:

- A) Melanose pustulosa transitória; antibiótico tópico.
- B) Miliária rubra; corticoide tópico de média potência.
- C) Eritema tóxico neonatal; lesão benigna, estéril e autolimitada, sem necessidade de tratamento.
- D) Impetigo bolhoso; cefalexina por 7 dias.

17. (Pele) Lactente de 8 meses com dermatite na área das fraldas há 10 dias, sem melhora com creme de barreira. O eritema é intenso, acomete as dobras inguinais e há pápulas satélites ao redor. Assinale a correta:

- A) É dermatite irritativa primária, que caracteristicamente acomete as dobras; usar lenços umedecidos a cada troca.
- B) A nistatina deve ser usada como creme de barreira em todas as trocas, de forma preventiva.
- C) Corticoide de alta potência por 4 semanas é o tratamento de escolha.
- D) Sugere candidíase: nistatina, miconazol ou cetoconazol creme por 2 semanas, mantendo o creme de barreira (óxido de zinco ou dexpantenol).

18. Adolescente de 15 anos com febre há 10 dias, odinofagia, placas amigdalianas, linfonodos cervicais posteriores, fadiga intensa e baço palpável. Após amoxicilina surgiu exantema difuso. Hemograma com 25% de linfócitos atípicos. Assinale a correta:

- A) Infecção por vírus Epstein-Barr; o anti-VCA IgM confirma; deve-se evitar esporte de contato pelo risco de ruptura esplênica.
- B) Escarlatina; o exantema decorre da toxina eritrogênica.
- C) O exantema indica alergia verdadeira à penicilina.
- D) A incubação curta, de 2 a 3 dias, é típica.

19. Sobre doenças exantemáticas, quantas afirmativas estão corretas?

I. No sarampo, as manchas de Koplik precedem o exantema, e febre que persiste após o exantema sugere complicação.

II. Na rubéola, a linfadenomegalia retroauricular e occipital precede o exantema em cerca de uma semana.

III. Na escarlatina, observam-se pele em lixa, sinal de Pastia e palidez perioral (Filatov).

IV. Na varicela, a profilaxia pós-exposição pode ser feita com vacina em até 5 dias ou imunoglobulina específica em até 10 dias.

20. (Urgência) Lactente de 18 meses, 10 kg, com diarreia e vômitos, vinha em Plano B. Agora está sonolento, com FC de 168 bpm, tempo de enchimento capilar de 4 segundos, extremidades frias e pulsos finos. A pressão arterial é de 90 × 55 mmHg. Assinale a correta:

- A) A pressão arterial normal exclui choque; deve-se manter o Plano B.
- B) Trata-se de choque hipovolêmico compensado: ABCDE, acesso venoso e Plano C (300 mL em 30 minutos e 700 mL em 2 horas e 30 minutos), guiando a próxima conduta pela resposta clínica.
- C) Antes de hidratar, colher coprocultura e PCR viral para definir o agente.
- D) Primeiro completar a história SAMPLE; depois iniciar o ABCDE.

21. Escolar de 9 anos, asmático, em crise: fala apenas palavras, saturação de 88%, tiragem intensa. Após oxigênio, 3 ciclos de salbutamol com ipratrópio e prednisolona, permanece grave. O próximo passo é:

- A) Sulfato de magnésio 50 mg/kg endovenoso (máximo 2 g) em 20 a 30 minutos.
- B) Acrescentar montelucaste.
- C) Manter ipratrópio durante toda a internação.
- D) Corticoide inalatório em dose alta.

22. Sobre a bronquiolite viral aguda, quantas afirmativas estão corretas?

I. Corticoide sistêmico reduz o tempo de internação.

II. Oxigênio está indicado com saturação abaixo de 92%.

III. O nirsevimabe é aplicado em dose única em menores de 1 ano.

IV. A nebulização com salina hipertônica é recomendada de rotina.

23. Menino de 4 anos com coqueluche confirmada. Em casa vivem a mãe, gestante de 30 semanas, e o pai, professor de educação infantil. A conduta para os contatos é:

- A) Profilaxia apenas se surgirem sintomas.
- B) Profilaxia apenas para a gestante.
- C) Penicilina benzatina para todos.
- D) Azitromicina por 5 dias para os contatos domiciliares, conferindo a dTpa da gestante (indicada a partir de 20 semanas em toda gestação).

24. (Asma) A base do tratamento de manutenção da asma é:

- A) Salbutamol em uso regular.
- B) Corticoide inalatório, orientando lavar a boca após o uso para prevenir candidíase.
- C) Antibiótico profilático.
- D) Brometo de ipratrópio diário.

25. Criança de 3 anos com febre e tosse há 3 dias, FR de 46 irpm, sem tiragem, saturação de 96%, bom estado geral e estertores em base direita. Assinale a correta:

- A) Não há taquipneia; o quadro é viral.
- B) Internação com ceftriaxona.
- C) Pneumonia sem sinais de gravidade; amoxicilina oral e reavaliação em 48 a 72 horas.
- D) Azitromicina como primeira escolha.

26. Criança de 4 anos com petéquias e equimoses há 2 dias, 3 semanas após um resfriado. Bom estado geral, sem visceromegalias. Hemoglobina 12 g/dL, leucócitos 8.000/mm³ sem blastos, plaquetas 12.000/mm³. Assinale a correta:

- A) Leucemia linfoide aguda; quimioterapia.
- B) Meningococcemia; ceftriaxona.
- C) Aplasia de medula; transplante.
- D) Púrpura trombocitopênica imune; a maioria resolve apenas com observação, reservando corticoide ou imunoglobulina para sangramento.

27. (Extra) Menino cujo pai mede 170 cm e a mãe 160 cm. A estatura alvo é:

- A) 171,5 cm (166,5 a 176,5 cm).
- B) 158,5 cm.
- C) 165 cm.
- D) 178 cm.

28. (Extra) Criança de 15 kg com OMA receberá amoxicilina 90 mg/kg/dia de 12/12 h. A suspensão é de 400 mg/5 mL. O volume por tomada é aproximadamente:

- A) 8,4 mL.
- B) 5 mL.
- C) 16,9 mL.
- D) 4,2 mL.

29. (Extra) Sobre a doença de Kawasaki, quantas afirmativas estão corretas?

I. O diagnóstico exige febre por 5 dias ou mais associada a 4 dos 5 critérios clínicos.

II. A conjuntivite é purulenta.

III. A imunoglobulina 2 g/kg deve ser feita idealmente até o 10º dia de febre.

IV. A plaquetose é típica da primeira semana.

30. (Extra) Adolescente de 15 anos procura contracepção. Assinale a correta:

- A) O injetável trimestral é combinado.

- B) O implante subdérmico tem alta eficácia e baixa dependência da usuária, e o preservativo deve ser recomendado pela proteção contra IST.
- C) O carbonato de cálcio, se suplementado, deve ser tomado longe das refeições.
- D) Métodos só de progesterona não trazem preocupação com massa óssea nessa idade.

Gabarito comentado do Simulado 2

Questão	Resposta	Por quê	Revisar
1	C (3)	I, II e IV corretas. III falsa: investiga-se acima de **90 dias** sem menstruar	Aula 10
2	D	Dismenorreia primária surge 2 a 3 anos após a menarca, com ciclos **ovulatórios**; AINE primeiro, anticoncepcional depois. Trimestral é só progesterona	Aula 10
3	A	Ginecomastia puberal fisiológica, bilateral e autolimitada: observar. Tamoxifeno só em casos selecionados; cirurgia acima de 5 cm, impacto grave ou acima de 15 anos	Aula 10
4	B (2)	I e III corretas. II falsa: o objetivo é autorregulação, não abstinência. IV falsa: a CFM 2.427/2025 veda hormonização abaixo de 18 anos (16 anos era a regra de 2019)	Aula 10
5	D	Progressão harmônica, idade óssea avançada, VC alta e LH puberal: central. Estradiol isolado tem baixa sensibilidade nas meninas	Aula 13
6	C (3)	I, II e III corretas. IV falsa: a periférica é desordenada e imprevisível	Aula 13
7	A	Lactente pode ter fígado a 2 a 3 cm; baço palpável já tem o dobro do normal; ausculta antes da palpação	Aula 11
8	C	Origem judaica, dores ósseas, esplenomegalia e citopenias com leucócitos normais, sem febre: Gaucher (caso 1 da aula)	Aula 11

Questão	Resposta	Por quê	Revisar
9	B (2)	I e III corretas. II falsa: na leucemia os leucócitos podem estar altos, normais ou baixos. IV invertida: periventricular é CMV, difusa é toxoplasmose	Aula 11
10	D	Irritada, olhos fundos, sedenta, prega lenta (2 ou mais sinais) e **pulso cheio**, sem nenhum sinal com asterisco: Plano B	Aula 8
11	A	Letárgico, não bebe, pulso fraco: Plano C. Abaixo de 1 ano: 30 mL/kg em 1 h (240 mL) e 70 mL/kg em 5 h (560 mL). A alternativa B é o esquema a partir de 1 ano	Aula 8
12	C	Quadro típico de estreptococo; teste rápido negativo exige cultura. Acima de 27 kg, penicilina benzatina 1.200.000 UI	Aula 3
13	D	OMA bilateral grave abaixo de 2 anos: antibiótico imediato. Creche e antibiótico recente: dose alta. Abaixo de 2 anos: 7 a 10 dias	Aula 3
14	A	Diplococo gram-negativo: meningococo. Ceftriaxona por 5 a 7 dias; profilaxia dos contatos íntimos	Aula 7
15	C (3)	I, II e III corretas. IV falsa: Listeria é naturalmente resistente às cefalosporinas (por isso ampicilina no RN)	Aula 7
16	C	**3º dia de vida, halo eritematoso, poupa palmas e plantas, assintomático: eritema tóxico, sem tratamento. A melanose pustulosa já está presente ao nascer e não tem eritem**a	Aula 14
17	D	Acometimento das dobras e lesões satélites: Candida (a irritativa poupa as dobras). Antifúngico tópico por 2 semanas; nistatina não é creme de barreira; evitar lenços umedecidos	Aula 14
18	A	Mononucleose: incubação longa (30 a 50 dias), exantema após amoxicilina sem ser alergia, linfócitos atípicos acima de 20%, risco de ruptura esplênica	Aula 15
19	D (4)	Todas corretas	Aula 15

Questão	Resposta	Por quê	Revisar
20	B	Taquicardia, TEC aumentado, extremidades frias e sonolência com PA preservada: choque compensado (hipotensão é tardia). Plano C a partir de 1 ano: 30 mL/kg em 30 min e 70 mL/kg em 2 h 30 min. SAMPLE e exames ficam para depois	Aula de Urgência
21	A	Crise grave refratária: sulfato de magnésio 25 a 75 mg/kg (máx. 2 g). Ipratrópio não tem benefício após a internação	Aula 5
22	B (2)	II e III corretas. Corticoide e salina hipertônica não são recomendados	Aula 6
23	D	Contatos domiciliares recebem azitromicina por 5 dias; gestante e profissional que trabalha com crianças são grupos prioritários	Aula 6
24	B	Corticoide inalatório é a base; candidíase e disfonia são os efeitos locais	Aula 5
25	C	De 12 a 60 meses, FR de 40 ou mais é taquipneia; sem sinal de perigo, tratamento ambulatorial com amoxicilina	Aula 4
26	D	Plaquetopenia isolada pós-viral, sem anemia, sem blastos e sem visceromegalia: PTI	Aula 1
27	A	Menino: (170 + 160 + 13) ÷ 2 = 171,5 cm, mais ou menos 5 cm. 158,5 seria a fórmula da menina	Aula 12
28	A	15 × 90 = 1.350 mg/dia; 675 mg por tomada; 675 ÷ 80 mg/mL = 8,4 mL	Aula 2
29	B (2)	I e III corretas. A conjuntivite é **não exsudativa**; a plaquetose aparece na **3ª semana**	Aula 15
30	B	Trimestral é só progesterona; carbonato se toma com refeição; métodos só de progesterona exigem cautela óssea	Aula 10

Distribuição das respostas: A 8, B 7, C 7, D 8. Se errou 2 ou mais no bloco 1 a 6, releia as Aulas 10 e 13 inteiras; se errou a 10 ou a 11, refaça o exemplo de cálculo do Plano C.

Questões extras: pele e urgência

Oito questões a mais sobre as duas aulas enviadas depois, com a resposta logo abaixo de cada uma. Cubra a resposta antes de ler. Nas de afirmativas: A) 1; B) 2; C) 3; D) 4.

E1. Lactente de 2 meses com placas eritematosas e escamas amareladas e gordurosas no couro cabeludo, sobrancelhas e região retroauricular, sem prurido. A conduta mais adequada é:

- A) Hidratante com ureia e corticoide oral.
- B) Vaselina ou óleo mineral para amolecer e remover as escamas; se necessário, hidrocortisona 1% por poucos dias ou cetoconazol 2%.
- C) Griseofulvina oral por 8 semanas.
- D) Permetrina 5% em todo o corpo.

Resposta: B. Dermatite seborreica (crosta láctea): 1º mês, sem prurido, autolimitada até 6 a 8 meses. Ureia e corticoide sistêmico são erros; griseofulvina é para tinea capitis.

E2. Sobre dermatite atópica, quantas afirmativas estão corretas?

I. No lactente, acomete a face poupando o maciço central e as superfícies extensoras.

II. No escolar, predomina nas dobras flexoras, como as fossas antecubitais e poplíteas.

III. Hidratantes à base de ureia são a primeira escolha.

IV. Os inibidores de calcineurina poupam corticoide e não causam atrofia, sendo úteis em face e dobras.

Resposta: C (3). I, II e IV corretas; III falsa: a aula orienta não usar hidratantes com ureia.

E3. Escolar de 7 anos com placa descamativa no couro cabeludo, com pelos quebrados rente à pele. O tratamento é:

- A) Cetoconazol creme por 4 semanas.
- B) Nistatina oral.
- C) Antifúngico sistêmico (por exemplo, griseofulvina) por 6 a 8 semanas.
- D) Mupirocina tópica.

Resposta: C. Tinea capitis exige tratamento sistêmico; o tópico serve para tinea corporis, cruris e pedis.

E4. Família com três filhos; o de 6 anos tem pápulas escoriadas com prurido que piora à noite, e o irmão de 1 mês tem lesões em palmas e plantas. Assinale a correta:

- A) Permetrina 5% para o de 6 anos e enxofre 5 a 10% para o de 1 mês, tratando todos os contatos íntimos ao mesmo tempo.
- B) Permetrina 5% para todos, inclusive o de 1 mês.

- C) Tratar apenas quem tem lesão.
- D) Ivermectina para o lactente de 1 mês.

Resposta: A. Escabiose: permetrina acima de 2 meses, enxofre abaixo de 2 meses, ivermectina só acima de 15 kg; contatos tratados juntos, com ou sem lesão.

E5. Sobre piodermites, quantas afirmativas estão corretas?

I. O impetigo bolhoso é causado praticamente sempre por S. aureus.

II. No impetigo de área limitada, o antibiótico tópico (mupirocina ou ácido fusídico) é a primeira linha.

III. O tratamento antibiótico do impetigo crostoso reduz o risco de glomerulonefrite pós-estreptocócica.

IV. A erisipela forma placa mal delimitada, e a celulite forma placa bem delimitada.

Resposta: B (2). I e II corretas. III falsa: o antibiótico não reduz o risco de GNDA. IV invertida: a erisipela é bem delimitada e a celulite é mal delimitada.

E6. Recém-nascido com mancha vermelho-violácea plana que ocupa metade da face e não some à compressão. A conduta é:

- A) Tranquilizar, pois desaparece no 1º ano.
- B) Propranolol oral imediato.
- C) Corticoide tópico.
- D) Investigar síndrome de Sturge-Weber com ressonância de encéfalo, neuropediatra e oftalmologista.

Resposta: D. Mancha vinho do Porto em hemiface: risco de Sturge-Weber (epilepsia, glaucoma). Propranolol é para hemangioma; desaparecer no 1º ano é a mancha salmão.

E7. Sobre a abordagem da criança gravemente enferma, quantas afirmativas estão corretas?

I. A taquicardia é sinal precoce de hipoperfusão.

II. A hipotensão arterial é achado tardio em pediatria.

III. A glicemia faz parte da avaliação do D (neurológico) no ABCDE.

IV. A história detalhada (SAMPLE) deve preceder a avaliação primária.

Resposta: C (3). I, II e III corretas. IV falsa: primeiro as ameaças à vida (ABCDE), depois a história detalhada.

E8. Criança de 18 meses em Plano B vomita uma vez após iniciar o soro de reidratação oral. Está irritada, mas com boa perfusão. A conduta é:

- A) Considerar falha da terapia oral e iniciar Plano C imediatamente.

- B) Suspender a hidratação por 6 horas.
- C) Manter a terapia oral em volumes pequenos e frequentes, reofertar e reavaliar (ondansetrona se vômitos persistentes).
- D) Iniciar antibiótico.

Resposta: C. Um vômito não é falha da TRO. Se continuar desidratado apesar disso, o cartaz indica sonda nasogástrica (gastróclise); se evoluir para desidratação grave, Plano C.

Banco 1: revisão geral (30 questões)

Faça as 30 em 60 minutos, sem consultar, marcando a resposta no papel. Só depois abra o gabarito. Nas questões de afirmativas, as alternativas são sempre: A) 1; B) 2; C) 3; D) 4.

1. Lactente de 18 meses, em uso de leite de vaca integral desde os 8 meses, é trazido por palidez. A mãe conta que ele "vive pedindo gelo". Hemoglobina 9,0 g/dL, VCM 68 fL, RDW 19%, reticulócitos baixos. A conduta mais adequada é:

- A) Ácido fólico por 3 meses.
- B) Ferro elementar 3 a 6 mg/kg/dia por 3 a 6 meses, com reavaliação em 30 a 45 dias.
- C) Transfusão de concentrado de hemácias.
- D) Ferro elementar 1 mg/kg/dia até os 2 anos.

2. Sobre o hemograma na pediatria, quantas afirmativas estão corretas?

I. O RDW elevado pode preceder a queda do VCM na deficiência de ferro.

II. A reação leucemoide caracteriza-se por leucócitos acima de 50.000/mm³ com predomínio de blastos.

III. Neutropenia grave corresponde a contagem de neutrófilos abaixo de 500/mm³.

IV. Na púrpura trombocitopênica imune da infância, a maioria dos pacientes necessita de corticoide.

3. Criança de 20 kg receberá amoxicilina 50 mg/kg/dia de 8/8 h. A suspensão disponível é de 250 mg/5 mL. O volume por tomada é:

- A) 6,7 mL.
- B) 5 mL.
- C) 10 mL.
- D) 13,3 mL.

4. Adolescente de 16 anos com febre, faringite exsudativa, adenomegalia cervical posterior e fadiga intensa recebeu amoxicilina. No segundo dia surgiu exantema máculo-papular difuso. Ao exame, baço palpável. Assinale a alternativa correta:

- A) Trata-se de alergia verdadeira à penicilina, e betalactâmicos devem ser contraindicados por toda a vida.
- B) O quadro é típico de escarlatina, e o exantema é causado pela toxina eritrogênica.
- C) O diagnóstico provável é mononucleose; espera-se linfocitose com linfócitos atípicos e deve-se orientar evitar esportes de contato.
- D) Trata-se de doença de Kawasaki, com indicação de imunoglobulina.

5. Menino de 8 anos, 22 kg, com início abrupto de febre de 39,5 °C, dor de garganta, exsudato amigdaliano e linfonodos cervicais anteriores dolorosos, sem tosse ou coriza. A conduta mais adequada é:

- A) Penicilina benzatina 600.000 UI IM em dose única.
- B) Amoxicilina com clavulanato por 10 dias como primeira escolha.
- C) Sintomáticos, pois a maioria das amigdalites é viral.
- D) Azitromicina por 5 dias como primeira escolha.

6. Lactente de 5 meses com febre de 38,2 °C e irritabilidade. A otoscopia mostra abaulamento da membrana timpânica direita. A conduta é:

- A) Observar por 48 a 72 h, pois a febre é menor que 39 °C.
- B) Cefalexina por 10 dias.
- C) Apenas gotas otológicas e analgésico.
- D) Amoxicilina.

7. Sobre a sinusite bacteriana aguda na criança, quantas afirmativas estão corretas?

I. O seio frontal desenvolve-se por volta dos 7 a 8 anos.

II. O diagnóstico exige radiografia dos seios da face.

III. Praticamente 100% das cepas de Moraxella catarrhalis produzem betalactamase.

IV. Sintomas persistentes por mais de 10 dias sem melhora constituem um dos critérios diagnósticos.

8. Lactente de 10 meses com febre e tosse há 3 dias. FR de 56 irpm, tiragem subcostal, saturação de 93%. A conduta mais adequada é:

- A) Amoxicilina ambulatorial e retorno em 48 h.
- B) Azitromicina ambulatorial por 5 dias.
- C) Internação e ampicilina endovenosa.
- D) Lavagem nasal e observação domiciliar.

9. Lactente de 7 semanas, afebril, com tosse em acessos curtos e taquipneia. Teve conjuntivite aos 15 dias de vida. Hemograma com eosinofilia. Agente e tratamento mais prováveis:

- A) Streptococcus pneumoniae; amoxicilina.
- B) Vírus sincicial respiratório; suporte.
- C) Staphylococcus aureus; oxacilina.
- D) Chlamydia trachomatis; azitromicina.

10. Sobre o derrame pleural parapneumônico, quantas afirmativas estão corretas?

I. Na fase exsudativa, o tratamento é feito apenas com antibiótico.

II. pH do líquido pleural abaixo de 7,1 indica drenagem.

III. A ultrassonografia detecta volumes menores que a radiografia em decúbito lateral.

IV. Na fase de organização, que ocorre em 2 a 4 semanas, pode ser necessária decorticação.

11. Escolar de 7 anos, asmático, em crise grave: fala apenas palavras, saturação de 89%. Recebeu 3 ciclos de salbutamol com ipratrópio e corticoide sistêmico, sem resposta. O próximo passo é:

- A) Sulfato de magnésio 25 a 75 mg/kg endovenoso, máximo de 2 g.
- B) Manter ipratrópio de 4/4 h após a internação.
- C) Iniciar montelucaste.
- D) Iniciar antibiótico de amplo espectro.

12. Sobre a asma na infância, quantas afirmativas estão corretas?

I. A espirometria deve ser realizada após o início do corticoide inalatório.

II. Abaixo de 5 anos, o diagnóstico é essencialmente clínico.

III. O montelucaste é o único antagonista de leucotrienos utilizado abaixo de 12 anos.

IV. O ipratrópio reduz hospitalização quando usado na emergência, sem benefício após a internação.

13. Lactente de 4 meses, no outono, com 2 dias de coriza e febre baixa, evolui com taquidispneia (FR 58), sibilos e crepitações difusas e saturação de 90%. É o primeiro episódio. A conduta adequada é:

- A) Nebulização com salina hipertônica e corticoide sistêmico.
- B) Oxigênio, aspiração nasal e hidratação.
- C) Salbutamol de horário e prednisolona.
- D) Palivizumabe.

14. Lactente de 2 meses, sem vacinas, com tosse há 12 dias. Após os acessos, apresenta cianose e apneia, sem guincho. Leucócitos 32.000/mm³ com 75% de linfócitos. Assinale a correta:

- A) O diagnóstico provável é coqueluche; tratar com azitromicina e fazer quimioprofilaxia dos contatos domiciliares.
- B) O diagnóstico provável é bronquiolite; o tratamento é de suporte.
- C) A ausência de guincho afasta coqueluche.
- D) A linfocitose indica infecção viral e dispensa antibiótico.

15. Sobre as doenças exantemáticas, quantas afirmativas estão corretas?

I. No exantema súbito, o exantema surge após o desaparecimento da febre.

II. No eritema infeccioso, a criança costuma estar febril durante a fase exantemática.

III. Na varicela, a transmissão persiste até que todas as lesões estejam em crosta.

IV. No sarampo, o exantema tem progressão craniocaudal e evolui com descamação furfurácea.

16. Recém-nascido de 15 dias com febre, irritabilidade e fontanela abaulada. Líquor: 1.200 células (85% neutrófilos), glicose 20 mg/dL, proteína 180 mg/dL. O esquema empírico adequado é:

- A) Ceftriaxona isolada.
- B) Vancomicina isolada.
- C) Aciclovir isolado.
- D) Ampicilina mais gentamicina (ou ampicilina mais cefotaxima).

17. Criança de 4 anos com febre há 3 semanas, cefaleia e paralisia do VI par craniano. Líquor: 250 células (80% linfócitos), glicose 15 mg/dL, proteína 300 mg/dL. O diagnóstico mais provável é meningite:

- A) Por enterovírus.
- B) Pneumocócica.
- C) Tuberculosa.
- D) Herpética.

18. Sobre meningites bacterianas, quantas afirmativas estão corretas?

I. Contatos domiciliares de doença meningocócica podem receber rifampicina de 12/12 h por 2 dias.

II. O profissional de saúde exposto a secreções durante intubação sem EPI deve receber quimioprofilaxia.

III. A ceftriaxona é contraindicada abaixo de 28 dias de vida.

IV. A dexametasona deve ser administrada antes ou junto da primeira dose de antibiótico.

19. Punção lombar traumática mostra 30 leucócitos/mm³ e 10.000 hemácias/mm³. O número de leucócitos corrigido é:

- A) 10.
- B) 20.
- C) 28.
- D) 30.

20. Criança de 1 ano que frequenta creche apresenta vômitos seguidos, um dia depois, de diarreia aquosa abundante. Assinale a correta:

- A) O mecanismo provável é secretor, que persiste com jejum.
- B) O agente mais provável é o rotavírus, com diarreia osmótica por deficiência de lactase.
- C) O antibiótico está indicado por frequentar creche.
- D) A alimentação deve ser suspensa até a melhora.

21. Sobre as diarreias, quantas afirmativas estão corretas?

I. O zinco é indicado na dose de 20 mg/dia por 10 dias para crianças acima de 6 meses.

II. Diarreia persistente é a que dura de 14 a 30 dias.

III. pH fecal abaixo de 5,5 sugere intolerância a carboidratos.

IV. O antibiótico está indicado em toda diarreia aguda abaixo de 2 anos.

22. Criança de 2 anos com diarreia crônica, distensão abdominal e queda do ganho de peso desde a introdução de pães e massas. O exame inicial mais indicado é:

- A) Anticorpo antitransglutaminase.
- B) Calprotectina fecal.
- C) ASCA.
- D) Teste do suor.

23. Escolar de 9 anos com desatenção na escola há 3 meses. Em casa, os pais não notam alterações. A conduta correta é:

- A) Confirmar TDAH e iniciar metilfenidato.
- B) Reconhecer que ainda não há critérios, pois são exigidos 6 meses de sintomas em 2 ou mais ambientes.
- C) Diagnosticar TEA nível 1.
- D) Iniciar atomoxetina como primeira linha.

24. Sobre desenvolvimento, TEA e TDAH, quantas afirmativas estão corretas?

I. O M-CHAT é aplicado entre 18 e 24 meses.

II. A dieta sem glúten e sem caseína tem evidência de benefício no TEA.

III. A atomoxetina tem início de ação imediato.

IV. Criança com atraso de linguagem deve ser encaminhada à fonoaudiologia.

25. Adolescente de 15 anos, menarca aos 12, com cólica menstrual intensa há 1 ano. A primeira linha de tratamento é:

- A) Anticoncepcional oral combinado.
- B) Opioide fraco.
- C) Dispositivo intrauterino.
- D) Anti-inflamatório não esteroide, como ácido mefenâmico.

26. Criança de 6 anos, do interior do Nordeste, com febre há 2 meses, emagrecimento, baço palpável a 10 cm do rebordo, pancitopenia e hipergamaglobulinemia. O diagnóstico e o tratamento são:

- A) Calazar; confirmar com amastigotas no mielograma e tratar com anfotericina B lipossomal.
- B) Leucemia linfoide aguda; quimioterapia.
- C) Doença de Gaucher; reposição enzimática.
- D) Mononucleose; sintomáticos.

27. Menino de 12 anos com estatura no percentil 2, velocidade de crescimento de 5 cm/ano e idade óssea de 10 anos. O pai relata que “cresceu tarde”. A estatura alvo é normal. O diagnóstico e a conduta são:

- A) Deficiência de GH; iniciar hormônio do crescimento.
- B) Baixa estatura familiar; tranquilizar.
- C) Síndrome de Turner; cariótipo.
- D) Atraso constitucional do crescimento; conduta expectante.

28. Uma menina tem pai com 180 cm e mãe com 164 cm. Sua estatura alvo é:

- A) 165,5 cm (160,5 a 170,5 cm).
- B) 178,5 cm.
- C) 172 cm.
- D) 159 cm.

29. Sobre a puberdade precoce, quantas afirmativas estão corretas?

I. Na menina, define-se pelo surgimento de caracteres sexuais antes dos 8 anos.

II. Nos meninos, a forma central é majoritariamente idiopática.

III. O teste de estímulo com GnRH é o padrão-ouro.

IV. Os análogos de GnRH tratam a puberdade precoce periférica.

30. Criança de 3 anos com febre há 7 dias sem resposta à amoxicilina, conjuntivite bilateral sem secreção, lábios fissurados, língua em morango, edema de mãos e linfonodo cervical de 2 cm. A conduta é:

- A) Penicilina benzatina IM.
- B) Aguardar a descamação periungueal para confirmar.
- C) Imunoglobulina endovenosa 2 g/kg com AAS, e ecocardiograma.
- D) Corticoide isolado.

Gabarito comentado do Banco 1

Para cada erro, volte à aula indicada e releia apenas o trecho citado; depois refaça a questão sem olhar.

Questão	Resposta	Por quê	Revisar
1	B	Microcitose, RDW alto, pagofagia e leite de vaca: ferropriva. Tratamento é 3 a 6 mg/kg/dia; 1 mg/kg/dia é dose de profilaxia	Aula 1
2	B (2)	I e III corretas. II falsa: leucemoide tem células maduras; blastos sugerem leucemia. IV falsa: 80 a 85% só observam	Aula 1
3	A	20 × 50 = 1.000 mg/dia; 333 mg por tomada; 333 ÷ 50 mg/mL = 6,7 mL. Atalho: 20 ÷ 3	Aula 2
4	C	Faringite, adenopatia posterior, fadiga, baço e exantema após amoxicilina: mononucleose. Não é alergia verdadeira	Aula 15
5	A	Quadro típico de estreptococo em escolar; abaixo de 27 kg, 600.000 UI. Amoxicilina com clavulanato fica para falha	Aula 3
6	D	Abaixo de 6 meses a OMA sempre recebe antibiótico; cefalexina não serve para OMA	Aula 3
7	C (3)	I, III e IV corretas. II falsa: o diagnóstico é clínico	Aula 3
8	C	Tiragem subcostal é critério de internação; a partir de 2 meses, ampicilina endovenosa	Aula 4
9	D	Afebril, 1 a 3 meses, conjuntivite prévia e eosinofilia: Chlamydia	Aula 4

Questão	Resposta	Por quê	Revisar
10	D (4)	Todas corretas	Aula 4
11	A	Crise grave refratária: sulfato de magnésio. Ipratrópio não ajuda após internação	Aula 5
12	C (3)	II, III e IV corretas. I falsa: espirometria antes do tratamento	Aula 5
13	B	Primeiro chiado abaixo de 2 anos no outono: bronquiolite. Suporte com O2 (saturação abaixo de 92%), aspiração e hidratação. Corticoide e salina hipertônica não são recomendados; palivizumabe só previne	Aula 6
14	A	Abaixo de 6 meses a coqueluche se apresenta com apneia e cianose, sem guincho; linfocitose é típica	Aula 6
15	C (3)	I, III e IV corretas. II falsa: não há febre na fase exantemática do eritema infeccioso	Aula 15
16	D	Recém-nascido: cobrir Listeria com ampicilina; ceftriaxona contraindicada abaixo de 28 dias	Aula 7
17	C	Linfocítica, glicose muito baixa, proteína muito alta, evolução arrastada e par craniano: tuberculose	Aula 7
18	D (4)	Todas corretas	Aula 7
19	A	10.000 ÷ 500 = 20; 30 menos 20 = 10	Aula 7
20	B	Vômitos antes da diarreia em lactente de creche: rotavírus, mecanismo osmótico. Manter alimentação; sem antibiótico	Aula 8
21	C (3)	I, II e III corretas. IV falsa: antibiótico só se grave, disenteria, imunossupressão ou abaixo de 4 meses	Aula 8
22	A	Diarreia crônica após introdução do glúten aos 1 a 3 anos: doença celíaca	Aula 8
23	B	TDAH exige 6 meses e 2 ambientes; ainda não preenche	Aula 9
24	B (2)	I e IV corretas. II falsa: sem evidência. III falsa: atomoxetina leva 2 a 4 semanas	Aula 9
25	D	Dismenorreia primária: AINE é primeira linha; anticoncepcional é a segunda	Aula 10

Questão	Resposta	Por quê	Revisar
26	A	Área endêmica, febre prolongada, baço enorme, pancitopenia e hipergamaglobulinemia: calazar	Aula 11
27	D	Idade óssea atrasada, VC normal, história paterna de crescimento tardio e alvo normal: atraso constitucional	Aula 12
28	A	Menina: (180 − 13 + 164) ÷ 2 = 165,5 cm, mais ou menos 5 cm	Aula 12
29	B (2)	I e III corretas. II falsa: nos meninos 2/3 têm lesão do SNC. IV falsa: análogo só na forma central	Aula 13
30	C	Febre de 5 dias ou mais com 4 critérios (conjuntivite, mucosa, extremidades, adenopatia): Kawasaki. Imunoglobulina até o 10º dia com AAS	Aula 15

Interpretação do resultado. 26 ou mais acertos: revise só os erros e as caixas “Como cai na prova”. De 20 a 25: releia as aulas dos erros na segunda à tarde. Abaixo de 20: priorize, nesta ordem, Aulas 7, 15, 3 e 4, que concentram o maior número de decisões terapêuticas.